BİLİŞSEL ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ VE KLİNİK SINAV STRATEJİSİ DOKTRİNİ

DUS (24 EKİM 2027) VE USMLE/INBDE PERSPEKTİFİNDEN BELLEK MİMARİSİ: 15 DERS, 220+ ÜNİTE VE 80/20 PARETO SİSTEMİ

"Yayınevi Sendromu" Otopsisi, İki Desteli Anki & Image Occlusion Mimarisi, DUSBANKASI Dijital Soru Motoru ve 4 Soru Bankası Triyajı, Serbest Geri Çağırma, Adımlı Örnekleme, Kova Triyajı, Ezber Kodlama Mühendisliği ve Anki Tabanlı Deneme Hata Otopsisi Protokolleri

Hedef Sınav: 24 Ekim 2027 DUS (120 Soru: 40 Temel + 80 Klinik)	**Sistem Prensibi:** Sıfır Overengineering & %100 Aktif Geri Çağırma (DUSBANKASI + İki Desteli Anki)

Yönetici Özeti ve Doktrin Manifestosu: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) gibi 15 disiplini ve 220'den fazla alt üniteyi kapsayan yüksek yoğunluklu sınavlarda başarısızlığın ana nedeni kaynak eksikliği veya çalışma süresi değil; **üretim yanılsaması ("yayınevi sendromu")**, **algısal akıcılık tuzağı** ve **tekrar yığılmasıdır**. Bu doktrin; Bjork ve Bjork (1992), Roediger ve Karpicke (2006), Kornell ve Bjork (2008), Karpicke ve Blunt (2011), Sweller ve ark. (2011) ile Dunlosky ve ark. (2013) tarafından kanıtlanan bilişsel yasaları, USMLE Step 1/Step 2 CK ve INBDE derece öğrencilerinin saha protokolleriyle, kendi inşa ettiğiniz **DUSBANKASI** dijital soru/deneme motoruyla ve **İki Desteli Öncelikli Anki Mimarisiyle** birleştirir. Bu belge, 24 Ekim 2027 sabahına kadar yeni materyal üretme dürtünüzü durduracak, elinizdeki devasa cephaneliği sadeleştirecek ve sizi sınava bozulmadan taşıyacak sabit ve değiştirilemez anayasanızdır.

BÖLÜM 1: Mevcut Durum Otopsisi - "Yayınevi Sendromu" Teşhisi ve Materyal Triyajı

1.1. Pembe Gözlükleri Çıkaralım: "Öğrenci miyim, Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni mi?"

Kendi yaptığınız özeleştiri, şu ana kadar verdiğiniz en değerli klinik karardır: "*Bir öğrenciden çok yayınevi gibi çalışıyorum.*" Bilişsel psikolojide bu durum **Üretkenlik Maskeli Kaçınma (Productive Procrastination)** ve **Koleksiyoncu Yanılsaması (Collector's Fallacy)** olarak tanımlanır. Beyin; soru çözerken yanlış yapmanın, iki şık arasında kalmanın veya boş kağıda konuyu anlatırken takılmanın yarattığı bilişsel acıdan (retrieval effort) kaçmak ister. Bunun yerine size kendinizi "çok çalışıyormuş ve kontrolü elinde tutuyormuş" gibi hissettiren konforlu ama düşük getirili işler icat eder: yapay zekaya zihin haritaları çizdirmek, ders notlarını tek yatay sayfaya sığdırmak, infografik tasarlamak veya binlerce yeni Anki kartı dizmek.

Gerçeklerle yüzleşelim: 24 Ekim 2027 günü ÖSYM size "En kapsamlı tek sayfa özeti kim hazırladı?" veya "En estetik zihin haritası kimde?" ödülü vermeyecek. Sınav günü masada yalnızca siz, 120 adet çoktan seçmeli soru ve neokorteksinizdeki **Depolama Gücü (Storage Strength)** olacak. Bir materyali hazırlamak, düzenlemek veya şematize etmek kodlama öncesi hazırlıktır (pre-encoding); bilgiyi sınavda çözdüren şey ise **geri çağırma pratiğidir (retrieval practice)**. Bugünden itibaren "içerik üreticisi" kimliğinizi tamamen kapatıyor ve %100 "soru/geri çağırma icracısı" kimliğine geçiyorsunuz.

1.2. Elinizdeki 7 Materyal Grubunun Cerrahi Denetimi (80/20 Karar Matrisi)

Elinizdeki her bir öğrenme aracını bilişsel getiri/zaman maliyeti oranına (Pareto 80/20 ilkesine) göre tek tek masaya yatırdık. Aşağıdaki tablo, hangi aracı derhal bırakacağınızı, hangisini donduracağınızı ve hangisine nasıl devam edeceğinizi gösteren kesin emir komuta zinciridir.

Materyal / Araç	Bilişsel Psikoloji Teşhisi	Kesin Karar	80/20 Doğru Kullanım Protokolü
1. Ana Konu Kitapları (Tek Kaynak)	Topografik (mekansal) belleğin ana çapasıdır. Sayfa düzeni ve görsel yerleşim değiştiğinde hafıza izleri silinir.	**DEVAM ET (TEK ANA KAYNAK)**	Her dersten yalnızca 1 ana konu kitabı masada kalacak. İlk derin kodlama (T+0) ve deneme/soru yanlışlarının mikro-okumaları (yama) yalnızca bu kitaptan yapılacak.
2. Hızlı Tekrar Modülleri (70-80 Sayfalık Özet Kitaplar)	Ana kitaptaki görsel-mekansal hafızayı (sayfanın sol altındaki tablo izini) bozar; çift kaynak çatışması yaratır.	**DERHAL BIRAK (RAFA KALDIR)**	Bu modülleri çalışma masanızdan kaldırın. Görsel hafızanızı korumak için tek kaynaktan ilerleme içgüdünüz %100 doğrudur.
3. AI Zihin Haritaları (Devasa Dallı Görseller + Image Occlusion)	Aşırı yabancı bilişsel yük (extraneous load) ve bölünmüş dikkat (split-attention) yaratır (Sweller ve ark., 2011).	**DERHAL BIRAK (%100 İLLÜZYON)**	Tablette hücre kapatıp açmayı ve yeni zihin haritası üretmeyi tamamen bırakın. Zihin haritası yalnızca T+0 sonunda 10 dakikada boş kağıda kendi elinizle çizdiğiniz kaba iskelettir (Karpicke ve Blunt, 2011).
4. Tek Yatay Sayfa "Atomik Özet" PDF'leri	Kıyas tabloları ve tuzak kutuları çok değerlidir; ancak 3 sütunlu yoğun düz metin kısmı akıcılık yanılsaması yaratır ve ana kitapla çakışır.	**ÜRETİMİ DURDUR, MEVCUDU FİLTRELE**	Yeni tek sayfa PDF üretmek yasaktır. Mevcut olanların ise sol/orta düz metin sütunlarını okumayın; sadece sağ alttaki "Çapraz Kıyas Tabloları", "En'ler" ve "İstisnalar/Tuzaklar" kutularını Image Occlusion ile Anki Öncelikli Desteye atmak veya T+3 kontrolü için kullanın.
5. Görsel İnfografikler (Sketchy Tarzı & 3B Şemalar)	Hikayeleştirilmiş görsel sahneler ikili kodlamayı (Paivio, 1986) tetikler; ancak metin ağırlıklı olanlar pasif okuma tuzağıdır.	**SEÇİCİ KULLAN (ÜRETİM KOTALI)**	Ders çalışma saatinde infografik üretmeyin. Mevcut infografiklerden sadece görsel hikaye (Sketchy) ve 3B uzaysal olanları Image Occlusion ile Anki Öncelikli Desteye alın; metin kutularını kapatıp görselden mekanizmayı sesli okuyun.
6. İki Desteli Anki Mimarisi (Öncelikli Deste + 9.000 Temel Bilim Destesi)	9.000 kartlık genel hacim klinik soru zamanını yutar; ancak deneme hataları ve saf ezber tabloları için FSRS algoritması manuel klasör takibinden çok üstündür.	**İKİ DESTELİ ÖNCELİK SİSTEMİ (45 DK KOTA)**	**Deste 1 (01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO):** Deneme yanlış cümleleri ve Image Occlusion ezber tabloları (Sabah ilk 15-20 dk'da sıfırlanır). **Deste 2 (02-ANA-TEMEL-BILIM):** FSRS (%86) ve Suspend (@) ile 3.000 karta budanmış deste (Kalan 25 dk'da çözülür, 45. dk'da kapatılır).

Materyal / Araç	Bilişsel Psikoloji Teşhisi	Kesin Karar	80/20 Doğru Kullanım Protokolü
7. DUSBANKASI Dijital Motoru + 4 Soru Bankası + Çıkmışlar + Denemeler	Sınav başarısının %80'ini belirleyen asıl motor güçtür (Deng ve ark., 2015). DUSBANKASI istediğiniz ders/üniteden istediğiniz sayıda karma soru seçip çözmenizi sağlayarak lojistik sürtünmeyi sıfırlar.	**ANA OMURGA (DİJİTAL & KADEMELİ TAHSİS)**	**DUSBANKASI:** Ünite bazlı T+0/T+3 seçimleri, Sarı/Kırmızı Kova testleri, karma branş denemeleri, 15 soruluk T+3 deneme doğrulama testleri ve Favoriler havuzu için ana komuta merkezidir. 4 Soru Bankası bu dijital ve fiziksel omurgada kademeli tüketilir.

1.3. Görsel Kanıtlarla Materyal Otopsisi: Neden Bazıları Bırakılmalı, Bazıları Dönüştürülmeli?

Mevcut materyallerinizi bilişsel yük ve görsel bellek ilkeleri açısından tek tek incelediğimizde, "üretim yanılsaması" ile "gerçek bilişsel kaldıraç" arasındaki sınır çok net biçimde ortaya çıkmaktadır:

> **Bilişsel Otopsi 1 - Yapay Zeka Zihin Haritası Tuzağı (DERHAL BIRAKILMALI):** "2017 Periodontal ve Peri-İmplant Hastalıklar Sınıflaması" görseli, dallanma sayısı 150'yi aşan mikroskobik düğümlerden oluşmaktadır. Sweller ve ark. (2011) tarafından tanımlanan Bilişsel Yük Teorisi'ne göre, bir şemayı okumak için tableti sürekli yakınlaştırıp uzaklaştırmak (zoom-in / zoom-out) çalışma belleğinin (working memory) tüm kapasitesini navigasyona harcar. Hücrelerin üzerini kapatıp açtığınızda beyniniz büyük resmi (üst dalın hangi ana sınıfa ait olduğunu) kaybeder. Ayrıca Karpicke ve Blunt (2011), hazır kavram haritaları üzerinden çalışmanın, boş bir kağıda 10 dakikada kendi elinizle ana başlıkları yazmaktan (Serbest Geri Çağırma) çok daha düşük kalıcılık sağladığını kanıtlamıştır.

Zihin haritası görselini tablette çözmek yerine yapmanız gereken işlem çok basittir: Periodontoloji kitabınızda 2017 sınıflaması bittiğinde kitabı kapatın, boş bir A4 kağıdına 4 ana sütun açın (1. Periodontal Sağlıklı/Gingivitis, 2. Periodontitis [Evre I-IV, Derece A-C], 3. Gelişimsel/Kazanılmış Mukogingival Durumlar, 4. Peri-implant Hastalıklar) ve alt kırılımları kendi zihninizden 5 dakikada yazın. Kendi beyninizin çizdiği çirkin bir şema, yapay zekanın çizdiği kusursuz bir posterden 10 kat daha fazla sinaptik bağ kurar.

> **Bilişsel Otopsi 2 - Hikayeleştirilmiş Görsel Hafıza Sarayı (DOĞRU KULLANIMLA ALTIN DEĞERİNDE):** Hazırladığınız "Leishmania infantum: İç Organların Siyah Humması (Kala-azar)" görseli, USMLE hazırlığındaki Sketchy Micro tekniğinin (Paivio, 1986 İkili Kodlama Kuramı) başarılı bir örneğidir. "Siyah Pazar (Kala-azar)", "Şişkin Karınlı Bebek (Masif Hepatosplenomegali)", "Çift Kırık Termometre (Günde iki kez çıkan ateş)", "Yırtık Kan Torbası (Pansitopeni)" ve sağ alttaki "Ayırıcı Tanı Radarı" (L. infantum vs. L. tropica vs. L. braziliensis) soyut mikrobiyolojik ezberleri mekansal bir sahneye kilitlemektedir.

Ancak diğer üç görseliniz olan Renk Sistemleri (Munsell vs. CIELAB), NK Hücresi ve Trichinella spiralis incelendiğinde kritik bir ayrım ortaya çıkar:

> **Bilişsel Otopsi 3 - Uzaysal/Geometrik Kıyas ve Ayırıcı Tanı Matrisi:** Munsell (Hue, Value, Chroma silindiri) ile CIELAB (L*, a*, b* kartezyen koordinatları ve ΔE > 3,6 klinik uyumsuzluk eşiği) karşılaştırması, sözel olarak okunduğunda soyut kalan 3 boyutlu bir kavramı somutlaştırdığı ve sağ sütunda doğrudan kıyas tablosu sunduğu için bilişsel olarak işlevseldir.

> **Bilişsel Otopsi 4 - Mekanizmik Akış ve Metaforik Kanca:** NK Hücresi görselinde "2. Nasıl Tanıyor? (Aktivasyon: MICA/B ve NKG2D vs. İnhibisyon: MHC-I ve KIR)" şeması ile sağ alttaki "Hafıza Çivisi (Kılıç: Perforin-Granzim, Kalkan: MHC-I, Radar: MICA/B, Megafon: IFN-γ)" kısmı hızlı geri çağırma için etkilidir; ancak sol ve alt kısımdaki uzun madde imli metin kutuları pasif okuma tuzağı taşır.

> **Bilişsel Otopsi 5 - "Yayınevi Sendromu"nun Kanıtı:** Trichinella spiralis görselinde ortadaki tür kıyas tablosu (T. pseudospiralis'in kas içinde kistleşmemesi) ve sağ alttaki "Yumurta dışkıda aranmaz, çünkü dişi vivipardır" tuzağı sınav kazandıran bilgilerdir. Ancak görselin sağ orta kısmındaki "REGUITİ" ve "TEDAVİ" kutularının birebir aynı 4 maddeyi tekrar etmesi ve yapay zeka dizgi hataları ("toyia tedavi"), bu kartları üretmek ve düzenlemek için harcadığınız zamanın marjinal getirisinin düştüğünü kanıtlamaktadır.

Görsel İnfografikler ve Tek Sayfa PDF'ler İçin Kesin Kural:

- **Üretim Yasağı:** Bugünden itibaren çalışma saatlerinizde yapay zekaya yeni infografik veya tek sayfa özet hazırlatmak kesinlikle yasaktır. Elinizde zaten yüzlerce saatlik hazır materyal var; artık üretim fazı bitti, hasat (geri çağırma) fazındasınız.
- **Tek Yatay Sayfa PDF'lerin ("TEK SAYFA TEKRARLAR.pdf") Doğru Kullanımı:** Restoratif Diş Hekimliği için hazırladığınız 17 sayfalık yatay özetlerin her sayfasında yaklaşık 1.200 kelime ve 12 kutu bulunmaktadır. Eğer bu sayfaları baştan sona okursanız, hem ana konu kitabınızdaki görsel hafızanızı bulandırırsınız hem de yoğun metin nedeniyle Algısal Akıcılık Yanılsamasına düşersiniz. **Bu yatay sayfaların sol ve orta sütunlarındaki düz anlatım kutularını okumayın!** Sadece her sayfanın sağ alt köşesinde yer alan "Çapraz Kıyas Tabloları" (örn. Mine vs. Dentin vs. Sement, 4.-8. Jenerasyon Adezivler, Gama-1 vs. Gama-2 vs. Eta fazı, Pin vs. Post lokalizasyon tuzakları), "High-Yield En'ler" ve "İstisnalar, Tuzaklar ve Kritik Farklar" kutularını, o ünitenin T+3 sorusunu çözdükten sonra 3 dakikalık "Ayırıcı Tanı Kontrol Listesi" olarak kullanın veya ekran görüntüsüyle doğrudan Anki Öncelikli Deste'ye (Image Occlusion olarak) atın.

1.4. 9.000 Adet Anki Kartının Otopsisi, İki Desteli Öncelik Mimarisi ve "Anki Cehennemi"nden Çıkış Protokolü

Paylaştığınız Biyokimya Anki kartı örneklerinizi bilişsel kart tasarım ilkeleri (**Wozniak, 1999** Minimum Information Principle) açısından inceleyelim:

```
Örnek 1: Karaciğerdeki glukokinaz enzimi, fruktoz 6-fosfat varlığında {{c1::GKRP
(glukokinaz düzenleyici protein)::düzenleyici protein}} aracılığıyla inhibe edilir.
Örnek 2: Glikolizin ikinci hız kısıtlayıcı basamağını katalizleyen ve fruktoz 6-fosfatı
fruktoz 1,6-bisfosfata çeviren enzim {{c1::fosfofruktokinaz-1 (PFK-1)::enzim}}'dir.
Örnek 3: Fosfofruktokinaz-1 (PFK-1) enzimi {{c1::fruktoz 2,6-bisfosfat ve AMP}} ile aktive
edilirken, {{c1::sitrat ve ATP}} ile güçlü biçimde inhibe edilir.
Örnek 4: Glikolizin üçüncü hız kısıtlayıcı basamağında fosfoenolpiruvatı (PEP) piruvata
çeviren enzim {{c1::piruvat kinaz::enzim}}'dır.
Örnek 5: Glikoliz enzimlerinden piruvat kinaz; {{c1::fruktoz 1,6-bisfosfat ve potasyum
(K+)}} ile aktive edilirken, {{c1::alanin}} amino asidi ile inhibe edilir.
Örnek 6: Piruvat, mitokondride {{c1::piruvat dehidrogenaz::enzim kompleksi}} aracılığıyla
geri dönüşümsüz (irreversibl) olarak {{c1::asetil CoA::ürün}} molekülüne çevrilir.
```

Kartlarınızın Bilimsel Değerlendirmesi ve 3 Kritik Tehlike:

1. **Kart Mikromimarisi (Olumlu Yön ve Küçük Revizyon):** Kartlarınız bağlamdan kopuk değil, atomik (tek bir önermeyi ölçen) ve ipucu etiketli (`::düzenleyici protein`, `::enzim`) olarak çok doğru kurgulanmıştır. Ancak Örnek 3, 5 ve 6'da aynı cümlede iki farklı boşluğun ikisine de `c1` vermişsiniz. Bu durumda kart açıldığında her iki boşluk aynı anda kapanır; bu da zıtlıkları (aktivasyon vs. inhibisyon) tek seferde hatırlamayı zorlayarak iyi bir kontrast sağlasa da, kartta takıldığınızda hangisini unuttuğunuzu algoritmaya ayrı ayrı bildiremezsiniz. Yeni düzenleme yaparak vakit kaybetmeyin, mevcut halleriyle kullanabilirsiniz.
2. **Tehlike 1 - Cümle Kalıbı Ezberleme (Syntax / Pattern Matching Tuzağı):** Aynı kartı 5. kez gördüğünüzde beyniniz artık biyokimyasal mekanizmayı düşünmez; cümlenin ilk üç kelimesini ("Glikolizin üçüncü hız...") gördüğü salisede refleks olarak "piruvat kinaz" der ve boşluk tuşuna basar. Sınavda ise ÖSYM aynı cümleyi kurmaz; "Açlık durumunda glukagon artışıyla fosforile olarak inaktive olan ve eksikliğinde hemolitik anemi görülen glikoliz enzimi..." diye sorar. **Çözüm:** Kartı açtığınızda cevabı 1 saniyede söyleyip geçmeyin; 3 saniye boyunca o enzimin zihninizdeki şemasını (örn. alanin neden inhibe eder? Çünkü alanin zaten piruvattan gelir, ürün inhibisyonudur!) canlandırın.
3. **Tehlike 2 - 9.000 Kartlık "Anki Çığı" ve Sınav Ağırlığı Çarpıklığı:** DUS'ta Temel Bilimler (Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji, Biyomateryal) toplam 40 soru (%33,3), Klinik Bilimler ise 80 soru (%66,7) getirir. Eğer sadece ezberi çok olan temel dersler için 9.000 Anki kartını her gün eksiksiz çevirmeye kalkarsanız, günde 600-800 kart tekrarı (yaklaşık 2-2,5 saat) yapmanız gerekir. Bu durum, sınavın üçte ikisini oluşturan Klinik Bilimlerin vaka sorularına ve branş denemelerine ayıracağınız en değerli zamanı felç eder!

İki Desteli Öncelik Mimarisi ve 5 Maddelik "Demir Disiplin" Protokolü:

- **Kural 1 - İki Ayrı Deste Kurulumu (Öncelikli Deste vs. Ana Deste):** Manuel klasör taşıma (1-4-7-14-30 gün) ve fiziksel hata defteri takip etme yükünü sıfırlamak için Anki'yi iki kademeli çalıştıracaksınız:
  1) `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` (Birincil Öncelikli Deste): Denemelerde yanlış yaptığınız soruların 1 cümlelik ayırt edici Cloze kuralları ve ünitelerdeki saf ezber tablolarının (Kırmızı Tablolar) Image Occlusion kartları yalnızca bu desteye girer. Bu deste sizin özelleştirilmiş en yüksek getirili (Pareto %20) cephaneliğinizdir; Sabah Blok 1'de ilk olarak bu deste %100 sıfırlanır (yaklaşık 15-20 dakika).
  2) `02-ANA-TEMEL-BILIM` (İkincil Ana Deste): Mevcut 9.000 kartlık temel bilim destenizdir. Sabah Blok 1'de Öncelikli Deste bittikten sonra kalan 20-25 dakikada bu desteye geçilir.
- **Kural 2 - FSRS Algoritmasına Geçiş ve %85-88 Hedef Tutma (Desired Retention):** Anki ayarlarından eski SM-2 algoritması yerine **FSRS (Free Spaced Repetition Scheduler)** algoritmasını aktif edin. `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesi için Desired Retention değerini **0.88**, `02-ANA-TEMEL-BILIM` destesi için **0.86 (veya 0.85)** yapın. Bu ayar, bilgiyi unutma sınırında yakalayarak günlük kart tekrar yükünüzü %35-40 oranında azaltacaktır.
- **Kural 3 - Ana Destede Acımasız Askıya Alma ("Suspend / @" Kuralı ile 9.000'den 3.000'e İndirme):** 9.000 kartın tamamı "yüksek volatiliteli" değildir. Örneğin, Örnek 6'daki "Piruvatın piruvat dehidrogenaz ile asetil CoA'ya dönüşmesi" bilgisini 2 kez doğru yaptıktan sonra bir daha unutmazsınız. Kart çalışırken "Ben bu bilgiyi artık refleks olarak biliyorum, mantığı oturdu" dediğiniz her kartta klavyeden **@ (Suspend / Askıya Al)** tuşuna basın! O kartı çöpe atmış olmazsınız, sadece günlük döngüden çıkarırsınız. Hedefiniz, 9.000 kartlık ana desteyi budayarak geriye sadece gerçekten unutulan 2.500-3.000 adet nankör ezber kartını (allosterik düzenleyiciler, interlökinler, CD belirteçleri, virüs reseptörleri, ilaç yan etkileri) bırakmaktır.
- **Kural 4 - Günlük 45 Dakika "Sert Tavan" (Timeboxing):** İki Anki destesinin toplamına günde yalnızca Sabah Blok 1'de **maksimum 45 dakika** ayıracaksınız. İlk 15-20 dakikada `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesini bitirecek, kalan 25 dakikada `02-ANA-TEMEL-BILIM` destesinden kart çekeceksiniz. 45. dakika dolduğunda ana destede kart kalsa bile Anki'yi kapatıp yeni konuya veya DUSBANKASI soru çözümüne geçeceksiniz. Anki sizin hizmetkarınızdır, efendiniz değil!
- **Kural 5 - Sadece "Aktif Üniteyi" Çözme (Un-suspend by Topic):** Ana destede henüz çalışmadığınız derslerin kartlarını kapalı (Suspended) tutun. Sadece o hafta çalıştığınız ve bitirdiğiniz ünitelerin kartlarını aktif (Un-suspended) hale getirin.

1.5. DUSBANKASI Dijital Soru Motoru, 4 Soru Bankası, Çıkmış Sorular ve Denemelerin Stratejik Tahsisi

Elinizde her ders için ortalama 4 soru bankası olması (15 ders × 4 kitap = 60 soru bankası / ~50.000+ soru) ve bunun yanında kendi inşa ettiğiniz **DUSBANKASI** projesinin bulunması size muazzam bir operasyonel üstünlük sağlamaktadır. Standart bir öğrenci farklı ünitelerden karma test oluşturmak veya T+3 doğrulama sorularını seçmek için fiziksel kitap sayfaları arasında boğulurken; siz **DUSBANKASI** üzerinden istediğiniz dersin istediğiniz ünitesinden istediğiniz sayıda soruyu saniyeler içinde seçip karma veya sıralı deneme oluşturabilir, çözebilir ve kritik soruları **Favorilere** ekleyebilirsiniz.

Ancak 60 soru bankasının tamamını 1. sorudan son soruya kadar düz sırayla çözmeye çalışmak **Tamamlama Saplantısı (Completionism Trap)** yaratır. Elinizdeki bu devasa soru cephaneliğini ve **DUSBANKASI** motorunu 80/20 ilkesiyle şu 5 kademeli görev mimarisine tahsis ediyoruz:

Soru Kaynağı / Platform	Bilişsel Rolü	Ne Zaman ve Nasıl Çözülecek? (DUSBANKASI Entegrasyonu)
Çıkmış DUS Soruları (Tüm Yıllar)	ÖSYM Kalibrasyon Pusulası	Asla son aya saklanmaz! Bir üniteyi ilk kez çalışırken (T+0 sonunda) veya o ders bittiği gün çözülür. Hangi alt başlığın ÖSYM tarafından defalarca sorulduğunu (Pareto %20 çekirdeği) gösterir. Sınava kadar toplam 3 kez taranır.
1. Soru Bankası ("Ana Edinim Bankası" / DUSBANKASI Ünite Modu)	İlk Kalibrasyon + Gecikmeli Geri Çağırma + Kova Triyajı	15 dersin tamamında %100 bitirilecek tek sıralı bankadır. Ünite bittiği gün (T+0) %20'lik kısmı (10 soru: fiziksel kitapta 5'in katları veya DUSBANKASI'nda 10 soruluk ünite örneklemesi), tam 3 gün sonra (T+3) ise kalan %80'lik kısmı (40 soru) çözülür. Bu testin sonucuna göre ünite Yeşil, Sarı veya Kırmızı Kovaya atanır.
2. Soru Bankası ("Cerrahi Onarım ve Doğrulama Bankası")	Sarı/Kırmızı Kova Onarımı + Deneme Hata Doğrulaması	Baştan sona sırayla çözülmez! Yeşil Kovaya giren (zaten ≥%85 yaptığınız) ünitelerin 2. soru bankasındaki testlerine dokunulmaz. Bu banka (veya DUSBANKASI'ndaki karşılığı) sadece: 1) Sarı Kovaya düşen ünitelerin T+14 doğrulama testlerinde (20-25 soru), 2) Kırmızı Kovaya düşen ünitelerin Cumartesi onarımında (30 soru) ve 3) Denemede yanlış çıkan ünitelerin T+3 günü DUSBANKASI üzerinden seçilerek çözülecek 15 soruluk doğrulama testlerinde kullanılır!
3. Soru Bankası ("Harmanlama / Interleaving Bankası" / DUSBANKASI Karma Mod)	Ayırt Edici Kontrast (Karma Tarama)	Bir ders tamamen bittikten sonra devreye girer. DUSBANKASI üzerinden o dersin tüm ünitelerinden karışık 30-40 soruluk **Karma Soru Blokları** tek tıkla oluşturulur (veya fiziksel 3. bankada her üniteden 2-3'er soru seçilir) ve haftalık bakımda çözülür.
4. Soru Bankası ("Klinik Baskınlık ve Kamp Bankası")	Klinik Vaka Derinliği ve Son 4 Ay Kamp Yakıtı	Temel Bilimlerde (40 soru) 4. soru bankasını çözmeye gerek yoktur (zaman israfıdır). 4. soru bankası yalnızca sınavın 80 sorusunu oluşturan **8 Klinik Bilim dersinde** (Protetik, Cerrahi, Perio, Restoratif, Endo, Pedo, Orto, Radyoloji) Faz 2 ve Faz 3'te vaka hızı kazanmak için kullanılır.
Branş Denemeleri & Genel / Online TG Denemeler	Sarmal Bakım ve Biyolojik/Bilişsel Sınav Simülasyonu	**Branş Denemeleri:** Biten her ders için Blok 4'te (7-10 günde bir) DUSBANKASI karma denemesi veya basılı branş denemesi olarak çözülür. **Genel ve TG Denemeler:** Pazar sabahları saat 10:15'te gerçek sınav ciddiyetiyle çözülür. Online Türkiye Geneli denemelere mutlaka girilir; ancak sıralamaya bakıp duygusal dalgalanma yaşamak yasaktır, tek amaç "Türkiye'nin takıldığı çeldiricileri" avlamaktır.

BÖLÜM 2: Bilişsel Öğrenme Psikolojisinin Temel Yasaları ve Sınav Yanılsamaları

2.1. Ebbinghaus Unutma Eğrisi, Sinaptik Konsolidasyon ve Nörobiyolojik Gerçeklik

Alman psikolog Ebbinghaus (1885) tarafından keşfedilen ve modern nörobilimle doğrulanan unutma eğrisi, yeni öğrenilen bilginin sinaptik düzeyde ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Hipokampüste geçici olarak kodlanan bilgi (erken dönem uzun süreli potansiyalizasyon - E-LTP), ilk 24 ila 72 saat içinde neokortekse aktarılmazsa ve geri çağırma çabasıyla (retrieval effort) uyarılmazsa hızla silinir. Pasif olarak okunan bir cerrahi veya mikrobiyoloji ünitesinin yaklaşık %50'si ilk 24 saatte, %70 ila %80'i ise 72. saatin (T+3 günü) sonunda erişilemez hale gelir.

Ancak bilişsel psikolojinin en kritik keşfi şudur: **Unutma, öğrenmenin düşmanı değil; kalıcı öğrenmenin ön koşuludur.** Beyin bir bilgiyi yalnızca onu unutma sınırına geldiğinde ve o bilgiyi bulmak için nöronal ağlarını zorladığında kalıcı protein sentezine (geç dönem LTP ve miyelinleşme) geçirir. Konuyu çalıştıktan hemen sonra (T+0) yapılan yoğun tekrar veya tüm soruların o an tüketilmesi, henüz hiç unutma başlamadığı için bu biyolojik mekanizmayı tetikleyemez.

2.2. Bjork'ün "Yeni Kullanmama Teorisi": Geri Çağırma Gücü vs. Depolama Gücü

Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Öğrenme ve Unutma Laboratuvarı direktörleri Bjork ve Bjork (1992), insan belleğinin tek bir güçle değil, birbirinden tamamen bağımsız iki farklı güçle çalıştığını kanıtlamıştır:

- **Geri Çağırma Gücü (Retrieval Strength):** Bir bilginin şu anki saniyede bilince ne kadar kolay ve hızlı gelebildiğini gösterir. Konuyu yeni okuduğunuzda veya özet PDF'inize baktığınızda bilgi çalışma belleğinde (working memory) ve kısa süreli hipokampal tamponda aktiftir; yani Geri Çağırma Gücü %100'dür. Ancak bu güç son derece uçucudur ve saatler içinde hızla düşer.
- **Depolama Gücü (Storage Strength):** Bilginin neokorteksteki mevcut şemalara ne kadar derin, kalıcı ve sağlam kök saldığını gösterir. 24 Ekim 2027 günü sizin netlerinizi belirleyecek olan tek güç Depolama Gücüdür.

Bjork ve Bjork (2011) tarafından formüle edilen **Arzu Edilen Zorluklar (Desirable Difficulties)** yasası şudur: **Geri Çağırma Gücü ne kadar yüksekse, o an yapacağınız tekrarın veya soru çözümünün Depolama Gücüne katkısı o kadar sıfıra yakındır.** Tam tersine, Geri Çağırma Gücü düştüğünde (yani konuyu çalıştıktan 2-3 gün sonra, bilgiyi hatırlamakta hafifçe zorlandığınızda) yapacağınız başarılı bir geri çağırma işlemi, Depolama Gücünü katlanarak artırır.

2.3. Anlama Yanılsaması (Illusion of Competence), Akıcılık Tuzağı ve Aşırı Öğrenme

Öğrencilerin %90'ının düştüğü en tehlikeli bilişsel tuzak **Tanıdıklık / Akıcılık Yanılsaması (Fluency Illusion)** olarak adlandırılır (Karpicke, Butler ve Roediger, 2009). Önünüzde ders kitabı, tek sayfa özet PDF veya zihin haritası açıkken metne baktığınızda, gözünüz cümleleri çok akıcı bir şekilde takip eder. Beyin bu "algısal akıcılığı" (perceptual fluency), "Ben bu konuyu çok iyi biliyorum ve öğrendim" şeklinde yanlış yorumlar. Oysa tanıdık gelmek (recognition) ile sıfırdan hatırlamak (cued/free recall) tamamen farklı nöral devreleri kullanır.

Benzer şekilde, **Roediger ve Karpicke (2006)** ile **Pashler ve ark. (2007)**, bir konuyu aynı gün içinde defalarca okuyup hemen arkasından 50 sorunun tamamını çözmenin (Aşırı Öğrenme / Overlearning) sadece o günkü testi yüksek çıkarttığını, ancak 1 hafta sonraki kalıcılığa neredeyse hiçbir ek katkı sağlamadığını göstermiştir.

2.4. Dunlosky Meta-Analizi: Çalışma Tekniklerinin Bilimsel Karnesi

Bilişsel psikoloji tarihinin en kapsamlı eğitim incelemelerinden biri olan **Dunlosky ve ark. (2013)** çalışması, öğrencilerin kullandığı çalışma tekniklerini yüzlerce deneysel araştırmayı tarayarak değerlendirmiştir. DUS 2027 hazırlığında zamanınızı nereye yatırmanız gerektiğini gösteren bilimsel bilanço aşağıdadır:

Çalışma Tekniği	Bilişsel Etki	Nörobilimsel Mekanizma	DUS 2027 Doktrinindeki Karşılığı
Geri Çağırma Pratiği (Practice Testing / Free Recall)	**Çok Yüksek**	Bilgiyi hafızadan dışarı çekmek (output), bilgiyi tekrar okumaktan (input) 3 kat daha güçlü sinaptik miyelinleşme sağlar (**Roediger ve Karpicke, 2006**).	Kitabı kapatıp 10 dk anlatma (Blurting), T+3 gecikmeli soru çözümü, Anki Öncelikli Deste (Image Occlusion tablolar + Hata Cloze) ve kotalı Ana Deste.
Aralıklı Pratik (Distributed Practice)	**Çok Yüksek**	Unutma sınırında yapılan geri çağırma ile sinaptik konsolidasyonu ve Depolama Gücünü maksimize eder (**Cepeda ve ark., 2006**).	T+0 (%20 soru) ve T+3 (%80 soru) bölünmüş test protokolü, Kova Triyajı ve FSRS algoritmalı Anki döngüleri.
Harmanlanmış Pratik (Interleaved Practice)	**Yüksek**	Farklı üniteleri karıştırarak çözmek beynin "Ayırt Edici Kontrast" (farkları bulma) yeteneğini keskinleştirir (**Kornell ve Bjork, 2008**).	DUSBANKASI üzerinden biten derslerin karma soru blokları, 3. Soru Bankası taramaları ve haftalık Branş Denemeleri.
Detaylandırıcı Sorgulama & Öz-Açıklama (Elaborative Interrogation)	**Orta-Yüksek**	"Neden böyle oldu?" sorusuyla yeni bilgiyi mevcut patofizyolojik ve klinik şemalara entegre eder.	Fizyoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Klinik derslerde mekanizma zinciri ve istisna mantığı kurma.
Özet Çıkarma / Şema Tasarlama (Summarization)	**Düşük**	Kaynak açıkken özet veya harita hazırlamak kopyalama işlemidir; yüksek zaman maliyetine karşın düşük geri çağırma üretir.	Yeni tek sayfa özet, zihin haritası ve infografik üretiminin tamamen durdurulması.
Tekrar Okuma ve Altını Çizme (Re-reading & Highlighting)	**Çok Düşük**	Sadece algısal tanıdıklık yaratır; aktif geri çağırma gerektirmediği için kalıcı belleğe etkisi minimaldir.	Aynı konu kitabını veya 70-80 sayfalık modülleri baştan sona pasif şekilde okumak (Kesin Yasak).

2.5. USMLE Step 1 / Step 2 CK (260+ Puan) ve INBDE Derece Öğrencilerinin 5 Sütunu

Kuzey Amerika uzmanlık ve yeterlilik sınavları (USMLE ve diş hekimliği INBDE/NBDE) üzerine yapılan ampirik araştırmalar (**Deng, Gluckstein ve Larsen, 2015**; **Augustin, 2014**), en üst %1'lik dilime giren adayların hiçbirinin ders kitaplarını baştan sona 3-4 kez okumadığını, bunun yerine şu beş sütunlu sistemi uyguladığını ortaya koymaktadır:

1. **Tek Seferlik Derin İlk Kodlama + Anında Serbest Geri Çağırma:** Konu ilk kez çalışılırken tek bir ana kaynaktan mekanizmalarıyla anlaşılır ve kitap kapatılarak ana iskelet zihinden boş kağıda dökülür.
2. **Soru Bankasını "Değerlendirme" Değil, "Birincil Öğrenme Aracı" Olarak Kullanmak:** Sorular konuyu unutmaya başladıkları T+3 gününde ve sonrasında karma (interleaved) modda çözülür; her sorunun 5 şıkkı da analiz edilir ("Diğer 4 şık hangi vakanın doğru cevabı olurdu?").
3. **İzole Ezberleri Konudan Ayırmak (Dekupaj):** Virüs reseptörleri, enzim regülatörleri, siman pH'ları, frez bıçak sayıları gibi mantığı olmayan saf ezberler konu kitabından ayrılarak mikro-aralıklı tekrar (kotalı Anki Öncelikli Deste / Image Occlusion) havuzuna atılır.
4. **Performans Sinyaline Dayalı Triyaj:** Her ünite eşit sıklıkta tekrar edilmez; testlerde %85 üzeri yapılan üniteler taburcu edilir, sadece zayıf halkalara (Sarı ve Kırmızı Kova) zaman yatırılır.
5. **Acımasız Hata Otopsisi ve Gecikmeli Doğrulama:** Denemelerde yapılan her yanlış, o konunun tamamını tekrar okumak için değil, zihindeki spesifik "kırık halkayı" aynı gün 5 dakikada onarmak, 1 cümlelik zıtlık kuralını akşam Blok 4'te doğrudan Anki Öncelikli Desteye girmek ve 3 gün sonra DUSBANKASI'ndan 15 soruluk mini testle doğrulamak için kullanılır.

BÖLÜM 3: Bilişsel Teknikler Ansiklopedisi - "Kitabı Kapat Anlat" ve Aktif Şema İnşası

3.1. "Kitabı Kapat ve 10 Dakika Anlat" Tekniği (Free Recall / Blurting / Feynman)

Purdue Üniversitesi'nden Karpicke ve Blunt (2011) tarafından *Science* dergisinde yayımlanan çığır açıcı araştırmada, öğrencilere bilimsel bir metin okutulmuş; bir gruba metni tekrar okuma, ikinci gruba metin açıkken kavram/zihin haritası çıkarma, üçüncü gruba ise **"Kitabı kapatıp aklında kalan her şeyi boş bir kağıda yazma / anlatma" (Serbest Geri Çağırma - Free Recall)** uygulanmıştır. Bir hafta sonra yapılan testte, kitabı kapatıp 10 dakika boyunca hatırladıklarını anlatan/yazan grup, zihin haritası çıkaran ve tekrar okuyan grupları büyük farkla geçmiştir.

Nasıl Uygulanmalı? (3+1 Kuralı):

- **Çalışma Sırasında (Her 3-4 Sayfada Bir 90 Saniyelik Mikro Geri Çağırma):** Ana konu kitabınızdan bir üniteyi baştan sona 25 sayfa kesintisiz okumayın. Her alt başlık bittiğinde (3-4 sayfada bir) başınızı kitaptan kaldırın ve 90 saniye boyunca: "*Az önce okuduğum bu 3 sayfada ana mekanizma neydi, sınıflama kaça ayrılıyordu ve sınavda buradan neyi çeldirici yaparlar?*" diye kendi kendinize sesli veya içinizden özetleyin. Takıldığınız an kitabı açıp o cümleye bakın.
- **Ünite Bittiği An (T+0 Sonu 10 Dakikalık "Boş Kağıt / Blurting" Seansı):** Ünite bittiğinde ana konu kitabınızı tamamen kapatın. Önünüze boş bir müsvedde A4 kağıdı alın (bu kağıt arşivlenmeyecek, saklanmayacak!). 10 dakika süre tutun. Ünitenin alt başlıklarını, kritik ayrımlarını ve mekanizmalarını sanki karşınızda bir dönem 3 öğrencisi varmış gibi anlatarak kağıda hızlıca oklar ve anahtar kelimelerle (tam cümle yazmadan, çöp adam hızıyla) dökün.

- **Boşluk Tespiti (Farkındalık Anı):** 10 dakika dolduğunda ana kitabınızı açın (veya o üniteye ait hazır Tek Sayfa PDF'inizin sadece sağ alt "Tuzaklar/En'ler" kutusuna bakın) ve kağıdınızla karşılaştırın. Anlatırken takıldığınız, karıştırdığınız veya tamamen unuttuğunuz alt başlıkları ana kitabınızda kırmızı yıldızla işaretleyin ve hemen o an 3-4 dakika içinde tekrar okuyun. İşte bu işlem, "Anlama Yanılsaması"nı daha tek bir test sorusu bile çözmeden %90 oranında yok eder!

3.2. Detaylandırıcı Sorgulama (Elaborative Interrogation) ve Klinik Mekanizma Zinciri

Konuyu ilk kez çalışırken (özellikle Patoloji, Fizyoloji, Farmakoloji, Endodonti, Periodontoloji, Restoratif ve Cerrahi gibi neden-sonuç ilişkisi barındıran derslerde) cümleleri ezberlemek yerine her kritik bilginin sonuna **"Neden?"** ve **"Peki bunun klinik sonucu ne olur?"** sorusunu eklemektir:

- **Örnek 1 (Restoratif / Simanlar):** "Polikarboksilat simanın başlangıç pH'ı (1,7), çinko fosfat simandan (3,5) çok daha asidik olmasına rağmen neden pulpayı irite etmez?" → *Neden?* Çünkü poliakrilik asit molekül ağırlığı çok büyük bir polimerdir ve dentin tübüllerinden içeri difüze olamaz! Bu bağlantıyı kurduğunuzda bilgi "ezber" olmaktan çıkar, yıkılmaz bir mantık zincirine dönüşür.
- **Örnek 2 (Restoratif / Çürüksüz Lezyonlar):** "Abfraksiyon neden mobil (periodontal desteği azalmış) dişlerde değil de periodontal desteği çok sağlam olan dişlerde görülür?" → *Neden?* Çünkü diş mobil olduğunda oklüzal kuvvet geldiğinde diş esner ve kuvveti dağıtır; oysa diş kemiğe rijit gömülüyse tüm bükülme (tensile/flexural) stresi servikal mine-sement sınırında patlar!

3.3. Harmanlama Etkisi (Interleaving Effect) vs. Blok Çalışma (Blocked Practice) ve DUSBANKASI Gücü

Kornell ve Bjork (2008), insan beyninin kavramları tek tek gruplayarak (AAABBBCCC - Blok Çalışma) değil, birbirine karıştırarak (ABCBCACAB - Harmanlama) çalıştığında çok daha üstün bir **Ayırt Edici Kontrast (Discriminative Contrast)** geliştirdiğini kanıtlamıştır. Örneğin Oral Patolojide sadece "Odontojenik Kistler" ünitesini çalışıp hemen arkasından üst üste 40 tane "Odontojenik Kist" sorusu çözdüğünüzde, beyniniz cevabın zaten o 5-6 kistten biri olduğunu bilir. Oysa kistler, odontojenik tümörler, dev hücreli lezyonlar ve fibro-osseöz lezyonlar bittikten sonra bunları **DUSBANKASI** üzerinden tek tıkla karıştırarak (Karma Branş Denemesi veya 3. Soru Bankasından Karma Blok) çözdüğünüzde, beyniniz her soruda "Bu vaka dentigeröz kist mi, unikistik ameloblastoma mı, yoksa adenomatoid odontojenik tümör mü?" sorusunu sormak zorunda kalır.

3.4. 15 DUS Dersinin Bilişsel Doğasına Göre Özel Strateji Matrisi

DUS'taki 15 dersin bilişsel yük yapısı ve sınavdaki soru getirisi aynı değildir. Aşağıdaki matris, 15 dersi bilişsel doğasına göre 3 gruba ayırarak elinizdeki araçları (Ana Kitap, İki Desteli Anki, DUSBANKASI ve Soru Bankaları) nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir:

Ders Grubu ve Dersler	Bilişsel Karakteristik	T+0 İlk Öğrenme Tekniği	T+3 ve Sonrası Tekrar & Araç Kullanımı
Grup A: Görsel-Mekansal ve Saf Ezber Ağırlıklı (Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya)	Düşük kavramsal hikaye, çok yüksek izole terim, komşuluk, enzim ve reseptör yükü. Çok hızlı unutulur.	**İkili Kodlama + Ayıklama:** Ana kitaptan çalış, saf ezber tablolarını Image Occlusion ile Anki Öncelikli Desteye at, 10 dk Boş Kağıt testi yap, 1. Bankadan 10 soruyu çöz.	**İki Desteli Anki + T+3 Testi:** Öncelikli Deste (Image Occlusion tablolar) + Budanmış Ana Deste Sabah Blok 1'de; 1. Bankanın kalan 40 sorusu T+3'te çözülür. 4. Soru Bankası çözülmez.
Grup B: Mekanizmik ve Nedensel (Fizyoloji, Patoloji, Farmakoloji, Biyomateryal / Maddeler Bilgisi)	Yüksek mantıksal zincir ve neden-sonuç ilişkisi. Anlaşılması zordur ama mantığı oturduğunda geç unutulur.	**Detaylandırıcı Sorgulama + Feynman:** Mekanizma oklarını çiz ("Neden?"), kitabı kapatıp süreci baştan sona sesli anlat, T+0 10 soru çöz.	**T+3 Vaka Soruları + Kova Triyajı:** Mantığı oturan üniteler T+3'te doğrudan Yeşil Kovaya geçer; sadece izole ilaç/özellik tabloları Image Occlusion olarak Anki Öncelikli Desteye alınır.
Grup C: Klinik Karar, Teşhis ve Protokol (80 Soru / %66,7) (Protetik, Cerrahi, Perio, Restoratif, Endo, Pedo, Orto, Radyoloji)	Sınıflamalar, endikasyon/kontrendikasyonlar, milimetrik sayısal eşikler ve ayırıcı tanı algoritmaları. Sınavın asıl belirleyicisidir.	**Karşılaştırmalı Tablo + Kitabı Kapat Anlat + T+0 Adımlı 10 Soru:** Benzer klinikleri (örn. pulpa patolojileri, seramik tipleri, kistler) yan yana kıyasla.	**T+3 Kalan 40 Soru + DUSBANKASI Karma Denemeleri + 4 Banka Derinliği:** Ayırıcı tanıyı keskinleştirmek için DUSBANKASI ve 1., 2., 3., 4. soru bankaları kademeli olarak sonuna kadar kullanılır.

BÖLÜM 4: Sıralı Soru Bankalarında Kapsam Kaybını Önleme - "Bölünmüş Test ve Adımlı Örnekleme" Protokolü

4.1. Soru Bankalarının "Sıralı Dizilim" Tuzağı

Türkiye'deki basılı DUS soru bankalarında (konu testlerinde) sorular rastgele dizilmez; konu kitabındaki alt başlıkların sırasına göre kronolojik olarak dizilir. Örneğin 50 soruluk bir "Diş Çekimi ve Gömülü Diş Cerrahisi" ünite testinde 1-10. sorular sadece çekim endikasyonlarını ve elevatör prensiplerini (ünitenin ilk 3 sayfasını), 11-25. sorular gömülü diş sınıflamalarını (Pell-Gregory, Winter), 26-40. sorular sinir yaralanmaları, oroantral açıklık ve alveoliti, 41-50. sorular ise postoperatif bakım ve antibiyotik profilaksisini tarar.

Eğer siz konuyu bitirdiğiniz gün (T+0) 1'den 10'a kadar olan ilk 10 soruyu çözüp bırakırsanız, sadece ünitenin ilk 3 sayfasını sınamış olursunuz; eğer 50 sorunun tamamını T+0'da çözerseniz, Geri Çağırma Gücü %100 olduğu için soruları yakmış (israf etmiş) olursunuz.

4.2. İki Aşamalı Kesin Çözüm: "Serbest Geri Çağırma" + "Adımlı Örnekleme (5'in Katları Kuralı / DUSBANKASI Seçimi)"

Hem 50 sorunun 40'ını T+3 gününe (gecikmeli geri çağırmaya) saklayıp hem de T+0 gününde ünitenin tamamını (%100'ünü) sınamak için şu iki adımı arka arkaya uyguluyoruz:

1. **Adım 1 - Bütünsel Tarama (10 Dakika "Kitabı Kapat ve İskeleti Çıkar"):** Soru bankasını açmadan hemen önce ana konu kitabınızı kapatıyorsunuz. 10 dakika boyunca ünitenin başından sonuna kadar tüm alt başlıkları boş kağıda anahtar kelimelerle döküyorsunuz. Kitabı açıp kontrol ettiğinizde, ünitenin hangi alt başlığını zayıf kodladığınızı daha tek bir soru bile çözmeden %100 görüyorsunuz.
2. **Adım 2 - Adımlı Soru Örneklemesi (Stride Sampling / "Her 5 Sorudan 1'i" Kuralı veya DUSBANKASI 10 Soruluk Karma Seçim):** Fiziksel 1. Soru Bankasındaki 50 soruluk ünite testini açtığınızda 1'den 10'a kadar olan soruları çözmüyorsunuz! Bunun yerine, toplam soru sayısını çözeceğiniz soru sayısına bölerek sabit adımlarla (örneğin 5'in katları olan soruları: **5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45. ve 50. soruları**) çözüyorsunuz (veya **DUSBANKASI** üzerinden o üniteden rastgele 10 soruluk bir kalibrasyon testi çekiyorsunuz).

Bu yöntemle yalnızca 10 soru harcayarak ünitenin ilk sayfasından son sayfasına kadar tüm alt başlıkların soruya nasıl dönüştüğünü kalibre edersiniz; her alt başlığın hemen yanındaki diğer 4 soru (1, 2, 3, 4 ve 6, 7, 8, 9. sorular) ise hiç görülmemiş şekilde 3 gün sonraki (T+3) esas geri çağırma antrenmanı için tertemiz kalır.

4.3. Somut Vaka Simülasyonu: Pazartesi (T+0) - Perşembe (T+3) Akışı

Zaman ve Aşama	Yapılacak Tam Eylem	Çözülen / Kalan Sorular	Bilişsel Kazanım ve Amacı
Pazartesi (T+0) 09:30 - 11:00 Derin Kodlama	Ana konu kitabından üniteyi çalış. Her 3-4 sayfada bir başını kaldırıp 90 sn özetle. Mekanizmaları ("Neden?") sorgula.	Henüz soru çözülmedi (0/50).	Bilginin ilk kez doğru şemalarla ve topografik (görsel) bütünlükle hipokampüse kodlanması.
Pazartesi (T+0) 11:00 - 11:10 Kitabı Kapat Anlat	Kitabı kapat. 10 dakikada tüm alt başlıkları boş müsvedde kağıda şematize et. Kitabı açıp unuttuğun yerleri kırmızıyla işaretle ve hemen oku.	Soru harcanmadan tüm konu (%100) tarandı.	Anlama Yanılsamasını (Illusion of Competence) sıfır soru maliyetiyle kırmak.
Pazartesi (T+0) 11:10 - 11:25 Adımlı Kalibrasyon	1. Soru Bankasındaki 50 soruluk testten sadece 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50. soruları (veya DUSBANKASI'ndan 10 soruyu + Çıkmış Soruları) çöz. Yanlış çıkanlara anında kitaptan bak.	10 Soru Çözüldü (Tüm ünite boydan boya örneklendi). 40 Soru Saklandı.	Yazarın ve ÖSYM'nin soru sorma stilini, sayısal eşikleri ve çeldiricileri tüm ünite genelinde kalibre etmek.
Salı ve Çarşamba Unutma Fazı (Nöral Dinlenme)	Bu üniteye hiç bakılmaz! Başka ders/üniteler çalışılır. Beynin bu üniteyi hafifçe unutmasına izin verilir.	Kalan 40 soru bekliyor.	Geri Çağırma Gücünün (Retrieval Strength) %100'den %70-75 bandına düşmesini sağlamak.
Perşembe (T+3) 14:30 - 15:20 Esas Geri Çağırma	Ana konuyu veya özet PDF'i tekrar okumadan doğrudan otur ve 1. Soru Bankasındaki kalan 40 soruyu (1-4, 6-9, 11-14 vb.) sınav ciddiyetiyle çöz.	Kalan 40 Soru Çözüldü (1. Bankada ünitenin tüm soruları bitti).	Unutma sınırındaki bilgiyi zorlanarak çekmek; Depolama Gücünü (Storage Strength) zirveye çıkarmak.

Zaman ve Aşama	Yapılacak Tam Eylem	Çözülen / Kalan Sorular	Bilişsel Kazanım ve Amacı
Perşembe (T+3) 15:20 - 15:35 Nokta Atışı Yama ve Kova Kararı	40 soruda yanlış yaptığın veya iki şık arasında kaldığın soruların ilgili paragraflarını ana kitaptan açıp 10-15 dk oku. Doğru sayısına göre üniteyi Kovaya ata.	50/50 Soru Bitti. Ünite Yeşil, Sarı veya Kırmızı Kovaya atandı.	Tüm konuyu baştan okuyup vakit kaybetmeden sadece 3 günde eriyen zayıf sinapsları onarmak ve gelecek takvimini belirlemek.

BÖLÜM 5: "Yeşil, Sarı ve Kırmızı Kova" (Triyaj) Sisteminin Operasyonel Mimarisi

5.1. Neden Klasik "1-3-7-15-30 Gün" Tekrarı 220 Ünitede Matematiksel Olarak Çöker?

Günde sadece 2 yeni ünite çalıştığınızı varsayalım ve her üniteye klasik "T+1, T+3, T+7, T+15, T+30" tekrarı koyalım. 30. güne geldiğinizde, o gün çalışmanız gereken 2 yeni ünitenin yanında; dünün 2 ünitesi, 3 gün öncenin 2 ünitesi, 7 gün öncenin 2 ünitesi, 15 gün öncenin 2 ünitesi ve 30 gün öncenin 2 ünitesi olmak üzere aynı gün tam **10 eski üniteyi** tekrar etmeniz gerekir! Bu matematiksel olarak imkansızdır ve sistemi 3. haftada çökertir. Çözüm, tıptaki acil servis **Triyaj (Ayıklama)** mantığıdır: Durumu iyi olan üniteler taburcu edilir (Yeşil), gözlem gerekenler müşahedeye alınır (Sarı), durumu ağır olanlar yoğun bakıma çekilir (Kırmızı).

5.2. T+3 Günü Kalan 40 Soruyu Çözdükten Sonra Yapılacak 2 Aşamalı İşlem

Konuyu çalıştıktan 3 gün sonra (T+3) 1. Soru Bankasından kalan 40 soruyu çözdünüz ve cevap anahtarından kontrol ettiniz. Şimdi sırasıyla şu iki işlemi yapıyorsunuz:

- **AŞAMA 1 - O Anki Standart Yama (Tüm Kovalar İçin Ortak, 10-15 Dakika):** Kaç yanlışınız çıkarsa çıksın, testi kontrol eder etmez yanlış yaptığınız veya iki şık arasında kalıp şans eseri doğru işaretlediğiniz soruların çözümünü okur ve **ana konu kitabınızdan sadece o yanlış çıkan soruların anlatıldığı paragrafları/tabloları açıp 10-15 dakika dikkatlice okursunuz.** Tüm üniteyi baştan sona okumazsınız!
- **AŞAMA 2 - "Bu Üniteyi Gelecekte Ne Zaman Göreceğim?" Kararı (Kova Triyajı):** Az önce çözdüğünüz 40 sorudaki başarı yüzdenize göre ünitenin kaderini ve 2. Soru Bankasının (veya DUSBANKASI doğrulama testlerinin) ne zaman devreye gireceğini belirlersiniz:

Kova Rengi ve Eşik	Bilişsel Teşhis	T+3 Günü (Aynı Gün) İşlemi	Takvime Eklenecek Gelecek Görevi ve DUSBANKASI / 2. Banka Rolü
YEŞİL KOVA 40 Soruda 34-40 Doğru (0-6 Yanlış / ≥%85 Başarı)	Araya 3 tam gün girmesine rağmen şema neokortekste sağlam (%85+).	Sadece yanlış çıkan 1-6 sorunun ilgili paragrafını ana kitaptan açıp 5-10 dakikada oku.	**HİÇBİR GÖREV EKLENMEZ (Taburcu).** Bu ünite için 2. Soru Bankası çözülmez! Ünite takviminden çıkarılır; sadece ders bittiğinde DUSBANKASI / 3. Banka karma bloklarında ve Branş Denemelerinde görülür.

Kova Rengi ve Eşik	Bilişsel Teşhis	T+3 Günü (Aynı Gün) İşlemi	Takvime Eklenecek Gelecek Görevi ve DUSBANKASI / 2. Banka Rolü
SARI KOVA 40 Soruda 28-33 Doğru (7-12 Yanlış / %70-%84 Başarı)	Ana iskelet oturmuş ancak bazı spesifik alt başlıklar veya sınıflamalar 3 günde erimiş.	Yanlış çıkan 7-12 sorunun ilgili alt başlıklarını ana kitaptan açıp 15 dakikada dikkatlice oku ve yıldızla işaretle.	**14 Gün Sonraya (T+14) - 20 Dakika:** Ajandaya tek bir görev yazılır: "*[SARI KOVA] İşaretli alt başlıklara 5 dk göz at + DUSBANKASI / 2. Soru Bankasından 1 test (20-25 soru) çöz.*" T+14'te başarı ≥%85 ise Yeşile mezun olur; <%70 ise Kırmızıya düşer.
KIRMIZI KOVA 40 Soruda ≤27 Doğru (13+ Yanlış / <%70 Başarı)	Alarm! İlk gün şema hiç oturmamış veya ünite aşırı nankör. 10 dk yama yetmez.	Yanlış soruların çözümlerini incele, hangi alt başlıkların çöktüğünü ana kitabın ünite başında not et. Günlük programı bozma.	**Cumartesi Gününe (Kova Onarım Bloğu) - 45 Dakika:** Çöken alt başlıkları 25 dk aktif (Boş Kağıt / Kıyas Tablosu ile) yeniden çalış + hemen DUSBANKASI / 2. Soru Bankasından 30 soru çöz. %80+ ise Sarı Kovaya (T+14'e 3. Bankadan test) terfi ettir.

BÖLÜM 6: "Bilmediğimi Biliyorum!" Saf Ezber Listelerinin Anki'de Tutulması, Çok Satırlı Tablo Protokolü ve Kodlama (Mnemonic) Mühendisliği

6.1. Kavramsal Şemalar vs. Keyfi Eşleşmeli Çağrışımlar (Arbitrary Paired-Associates)

Bilişsel psikolojide (Tulving, 1972; Sweller ve ark., 2011) bellek materyalleri ikiye ayrılır:

1. **Anlamsal / Mekanizmik Şemalar (Conceptual Schemas):** Örneğin "Hidrodinamik Teori (Soğukta sıvının dışarı akışı ve A-delta uyarımı)" veya "Tip I Aşırı Duyarlılık". Bunların bir hikayesi ve fiziği vardır; T+0 ve T+3 döngüsüyle aylarca unutulmaz.
2. **Keyfi Eşleşmeli Çağrışımlar (Arbitrary Paired-Associates / Saf Ezber Tabloları):** Örneğin Mikrobiyolojideki "Virüs - Hücre Reseptörü" tablosu, Biyokimyadaki "Glikoliz Allosterik Düzenleyicileri", Anatomideki "Kafa Tabanı Foramenleri", Restoratifteki "ICDAS Kodları, DIAGNOdent Eşikleri (5-25, 25-35, >35), Flor ppm Değerleri (225, 900, 1450, 5000, 12.300, 22.600, 44.500, 80.000), Pin Çapları (Minuta 0,38, Minikin 0,48, Minim 0,61, Regular 0,78 mm)" veya Pedodonti/Ortodontideki "Kalsifikasyon/Sürme Yaşları ve Sefalometrik Açılar". Bu bilgilerin hiçbir mantıksal hikayesi yoktur!

Altın Kural: Saf ezber tablolarının unutma eğrisi, ünitenin geri kalanından 5 kat daha diktir. Bu yüzden saf ezber tablolarını ünite tekrarından tamamen ayırıp (dekupaj) doğrudan Anki'deki **`01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` (Öncelikli Deste)** içine Image Occlusion olarak alıyor ve FSRS algoritmasının yönettiği günlük mikro-döngüye sokuyoruz.

6.2. Ezber Listelerini Anki'de Nasıl Tutmalıyım? (Image Occlusion ve Çok Satırlı Tablolarda "Good vs. Again" Protokolü)

Tablette 1-4-7-14-30 günlük manuel klasörler açıp ekran görüntülerini klasörler arasında elle taşımak yerine, tekrar zamanlamasını %100 Anki'nin FSRS algoritmasına devrediyoruz. Ancak 8-10 eşleşmeli bir ezber tablosunu Anki'ye eklerken ve çalışırken sistemi kilitlememek için şu **4 Cerrahi Kuralı** uygulayacaksınız:

- **1. Kapatma Mimarisi (8 Ayrı Kart Değil, 1 veya Maksimum 2 Kart):** 8 eşleşmeli bir tabloyu 8 ayrı Image Occlusion kutusuyla 8 karta bölmek, kart sayısını sekize katlayarak 45 dakikalık sabah kotanızı patlatır ve tablonun bütüncül kıyas (kontrast) üstünlüğünü bozar. Bunun yerine:
  • Tablo 4-6 satırsa sağ sütunun (cevapların/sayıların) tamamını **tek bir dikdörtgen kutuyla (1 kart)** kapatın.
  • Tablo 8-10 satırsa sağ sütunu **üst 4 satır (Kutu 1)** ve **alt 4 satır (Kutu 2)** olarak iki büyük blok halinde kapatıp **"Hide All, Guess One" (Hepsini Gizle, Birini Tahmin Et)** seçeneğiyle **maksimum 2 kart** üretin.
- **2. Yeni Eklenen Tablolarda (Öğrenme Fazı / İlk 2-3 Gösterim) Karar Ölçütü:** Tabloyu yeni öğrenirken (ilk birkaç gün) 8 eşleşmeden 1-2 tanesini bile hatırlayamazsanız görsel iskelet henüz oturmamış demektir; acımadan **Again (Tekrar)** tuşuna basın. Tüm listeyi eksiksiz saydığınızda **Good (İyi)** basarak kartı mezun edin.
- **3. Olgunlaşmış Tablolarda (Review Fazı) "1-2 Fire" Tuzağı ve Çözümü:** Haftalar sonra karşınıza gelen 8 satırlık bir tablonun 6-7 satırını saniyeler içinde takır takır sayıp sadece 1-2 inatçı satırı unuttuğunuzda **Again** basarsanız, zaten çok iyi bildiğiniz diğer 7 satırı da cezalandırıp tabloyu sonsuz bir "Anki Cehennemi" döngüsüne sokarsınız. Olgun bir tabloda 8'de 6 veya 7 yaptığınızda (yani sadece 1-2 fire verdiğinizde), unuttuğunuz o 1-2 maddeye 5 saniye dikkatlice bakıp sesli tekrar edin ve tabloya **GOOD (veya Hard)** basın!
- **4. "Cerrahi Ayırma" (İnatçı Tekil Maddeye Atomik Cloze Açma):** Eğer o tabloda unuttuğunuz 1-2 madde, tablo bir sonraki gelişinde **yine** kaçarsa; yine tabloyu sıfırlamayın! Tabloya **Good** basın ve hemen o an klavyeden `A` (Add) tuşuna basarak sadece o inatçı tekil eşleşme için 10 saniyede 1 cümlelik ayrı bir **Cloze kartı** açıp `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesine ekleyin (Örn: `Parvovirüs B19, eritrosit öncüllerine {{c1::P antijeni (Globozid)}} reseptörüyle bağlanır`). Böylece koca tablo 14-30 günlük uzun aralıklara rahatça açılırken, sadece takıldığınız o tekil pürüz sabah döngüsünde sık tekrar edilir!

Tablo Durumu ve Performans	Basılacak Anki Tuşu	Yapılacak Bilişsel Eylem ve Gerekçesi
Yeni Tablo (İlk 2-3 Gösterim) 1 veya daha fazla fire var	**AGAIN (1)**	Görsel şema ve bütünsel kıyas henüz hipokampüste oturmamıştır. Tüm listeyi eksiksiz sayana kadar aynı gün içinde tekrar görülür.

Tablo Durumu ve Performans	Basılacak Anki Tuşu	Yapılacak Bilişsel Eylem ve Gerekçesi
Olgun Tablo (Review) 8'de 8 veya 8'de 7-6 Doğru (Sadece 1-2 Fire)	**GOOD (3)** *(veya Hard)*	Bildiğiniz 6-7 maddeyi 1 fire yüzünden başa sarmayın. Kaçırdığınız 1-2 maddeyi 5 saniye sesli kodlayıp Good basın. Eğer aynı 1 madde ikinci kez kaçarsa, tabloya yine Good basıp sadece o madde için ayrı bir **Tekil Cloze Kartı** açın (Cerrahi Ayırma).
Olgun Tablo (Review) 3 veya daha fazla fire var (Tablo Çökmüş)	**AGAIN (1)**	Tablonun yarısına yakını silinmiştir. 60 saniye boyunca ses/görsel kancaları (Mnemonic) yeniden kurun ve Again basarak tabloyu yeniden inşa döngüsüne sokun.

6.3. Bilimsel Kodlama (Mnemonic) Mühendisliği: Kendi Kodlamalarınızı 60 Saniyede Nasıl Kurarsınız?

İnsan beyni soyut harf ve sayı dizilerini (CD21, ICAM-1, 0,48 mm, %1,23 APF, gama-2 fazı) tutamaz; ancak **fonolojik (ses benzerliği), görsel-mekansal ve absürt/duygusal kancaları** asla unutmaz (Paivio, 1986; Bellezza, 1981). Herhangi bir saf ezber bilgisini 60 saniyede kalıcı hafızaya kilitlemek için şu 4 Kodlama Arketipini kullanacaksınız:

1. **Arketip 1 - Fonolojik Kök Eşleşmesi (Ses Kancası):** Kelimenin içindeki heceyi Türkçe somut bir nesneye bağlayın. (Örn. Epstein-**BAR** virüsü → **BAR**'a girme yaşı **21**'dir → **CD21**).
2. **Arketip 2 - Boyut / Şiddet Sıralama Kancası (Morfolojik Kanca):** Kelimenin uzunluğu veya harf yapısı ile sayısal değeri eşleştirin. (Örn. Vidalı dentin pinlerini dar olandan geniş olana sıralarken: Minu-**TA** [en küçük "ta" bebek: 0,38 mm] < Mini-**KİN** [0,48 mm] < Mi-**NİM** [0,61 mm] < **REGU-LAR** [standart büyük: 0,78 mm]).
3. **Arketip 3 - Zıtlık / İstisna Çarpışması (Kutuplaştırma Kancası):** İki benzer kavramdan sadece istisna olanı kodlayın; diğeri otomatik olarak kural olur. (Örn. Dentin pini ve Endodontik post lokalizasyon zıtlığı: Mandibular Molar Distal ve Maksiller Molar Palatinal kökler en geniş/düz kanaldır; bu yüzden **POST için en ideal** yerdir, ama **PİN için kesinlikle yasak** (perforasyon) bölgesidir! "*Postun cenneti, pinin cehennemidir*").
4. **Arketip 4 - Hikayeleştirilmiş Mekanizma Kancası (Biyokimya / Farmakoloji):** Enzim veya ilacı bir kişilik gibi düşünün. (Örn. Anki kartınızdaki Piruvat Kinaz: Glikolizin son kapısında duran bekçidir. Yukarıdan gelen kalabalık [Fruktoz 1,6-bisfosfat - ileri besleme / feed-forward] kapıyı zorla açar [aktive eder]; ama içeride zaten piruvattan üretilen Alanin ve ATP birikmişse bekçi kapıyı kilitler [inhibe eder]).

6.4. Temel ve Klinik Bilimlerden Yüksek Volatiliteli DUS Kodlama Örnekleri Tablosu

Elinizdeki Anki kartları, Tek Sayfa PDF'ler ve temel bilim tablolarındaki en nankör ezberlerin bilimsel kancalarla nasıl kodlandığını gösteren referans tablo aşağıdadır:

Ders ve Konu	Saf Ezber Bilgisi (Hedef Bilgi)	Bilişsel / Fonolojik Hafıza Kancası (Dual-Coding Hikayesi)
Mikrobiyoloji Virüs Reseptörleri	• EBV → CD21 • Rinovirüs → ICAM-1 • Kuduz → Nikotinik ACh • Parvovirüs B19 → P antijeni • HIV → CD4 + CCR5 / CXCR4	• **BAR**'a (EBV) girme yaşı **21**'dir (CD21). • Nezlede (Rino) hapşırırken elindeki **CAM** (ICAM-1) bardağı kırarsın. • Kuduzda kaslar kasılır → kas-sinir kavşağı anahtarı **Asetilkolin (ACh)**. • **P**arvovirüs = **P** antijeni (Globozid). • HIV önce **5. vitesle** (CCR5 - Erken/Makrofaj) başlar, sonra **4 çeker** (CXCR4 - Geç/T-hücre) olur.
Biyokimya Glikoliz Regülasyonu (Anki Kartlarınız)	• Glukokinaz inh: F6P + GKRP • PFK-1 akt: F-2,6-BP, AMP • Piruvat kinaz akt: F-1,6-BP; inh: Alanin	• Karaciğerdeki Glukokinaz zengin ağadır; F6P birikince GKRP polisi onu çekirdeğe hapseder. • PFK-1 glikolizin "1" numaralı patronudur; ikizi olan F-2,6-BP onun en güçlü dopingidir. • Piruvat Kinaz son kapıdır: Üstteki F-1,6-BP arkadan iter (aktive), piruvatın kardeşi Alanin önden durdurur (inhibe).
Restoratif Amalgam Fazları ve Korozyon	• Gama (γ): Ag_3Sn (En güçlü) • Gama-1 (γ_1): Ag_2Hg_3 (%60 matris) • Gama-2 (γ_2): $Sn_{7-8}Hg$ (En zayıf) • Eta (η): Cu_6Sn_5 (Yüksek Cu)	• **Gama (Orijinal Gümüş-Kalay):** Civa değmemiş saf çekirdektir → En güçlü ve en dirençli katot. • **Gama-2 (Sn-Hg):** "2 yüzlü Kalay (Sn) civa ile birleşince çürür" → Bıçak kristalli, en zayıf, en çok korozyona uğrayan anot! • **Bakır (≥%13 Cu)** gelince Kalay'ı civanın elinden alır (Cu-Sn = Eta) ve Gama-2'yi yok eder.
Restoratif Burnishing vs. Carving Yönü	• Burnishing: Restorasyondan → Dişe • Carving: Dişten → Restorasyona	• **Burnishing (Birleştirme/Adaptasyon):** Amalgamı kavite kenarına **B**astırarak kapatmak için içeriden dışarıya (restorasyondan dişe) itilir. • **Carving (Kazıma):** Mine kenarını referans alıp çukurlaştırmamak için bıçak dışarıdan içeriye (dişten restorasyona) çekilir.
Restoratif HEMA ve 10-MDP Çelişkisi	• 10-MDP: Ca ile en güçlü kimyasal bağ (nano-tuz) • HEMA: Islanabilirliği artırır ama 10-MDP-Ca bağını bozar!	• **10-MDP** kalsiyumla evlenmek (kimyasal nano-tuz bağı) ister; **HEMA** ise araya giren meraklı komşudur: ortamı ıslatır (faz ayrılmasını önler) ama 10-MDP ile Kalsiyumun baş başa kalmasını (kimyasal bağı) engeller!
Restoratif Florür PPM Merdiveni	• Günlük gargara: 225 ppm • Haftalık gargara: 900 ppm • Macun: 1.450 / Reçeteli: 5.000 • APF Jel: 12.300 ppm • NaF Vernik: 22.600 ppm • SDF (%38): 44.500 ppm • SnF_2 (%8): 80.000 ppm	• PPM Basamakları: %1 oranı = 10.000 ppm demektir (Sadece virgülü 4 basamak sağa kaydır, F ağırlık oranıyla çarp!). • **APF Jel (%1,23 F)** → Rakamlar sırayla: **1 - 2 - 3** → **12.300 ppm!** • **NaF Vernik (%5 NaF)** → İki tane 2, toplamı 6: **22.600 ppm!** • **Kalay Florür (%8 SnF_2)** → 8 × 10.000 = **80.000 ppm** (En yüksek ppm!).
Restoratif / Endo Beyazlatma Kimyası	• Süperoksol: %35 HP + Su • Pyrozon: %25 HP + Eter • %10 Karbamid Peroksit = ~%3 HP + %7 Üre	• **Süper-Su:** Süperoksol = Su bazı (%35 HP). • **Pyro (Ateş/Uçucu):** Ateş gibi uçucu olan Eter bazlı (%25 HP). • **Karbamid Peroksit 10'luk:** Üçte biri (%3,3) aktif HP'dir, kalanı (%7) pH'ı yükselten Üre'dir.

BÖLÜM 7: Biten Derslerin Bakımı, DUSBANKASI Branş Denemeleri ve Anki Tabanlı "Deneme Yanlış Havuzu"nun Somut Mimarisi

7.1. Biten Koca Bir Dersin Sarmal Bakım ve Branş Denemesi Sıklığı

Bir dersi tüm üniteleriyle (ve 1. Soru Bankasındaki T+3 çözümleriyle) bitirdiğiniz andan itibaren, o ders artık "Edinim (Acquisition) Fazı"ndan **"Bakım ve Harmanlama (Maintenance & Interleaving) Fazı"**na geçmiştir. Bu aşamada yapılacak en büyük hata, 1 ay sonra "Ben bu dersi unuttum galiba, kitabı 1. sayfadan açıp baştan sona bir daha okuyayım" demektir. Bunun yerine dersin unutulma katsayısına ve sınav ağırlığına göre **DUSBANKASI Karma Branş Denemesi (veya 3. Soru Bankasından Karma Blok)** döngüsü uygulanır:

- **Yüksek Soru Ağırlıklı Klinik Bilimler (Protetik, Cerrahi, Perio, Restoratif, Endo, Pedo, Orto, Radyoloji - 80 Soru):** Ders bittikten sonra **her 7 günde bir (haftada 1 kez)** DUSBANKASI üzerinden o dersin tüm ünitelerini karışık tarayan 1 adet Branş Denemesi (veya 3. Soru Bankasından 30 soruluk Karma Blok) çözülür.
- **Yüksek Volatiliteli Temel Bilimler (Anatomi, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Histoloji):** Ders bittikten sonra **her 7 ila 10 günde bir** DUSBANKASI'ndan 1 adet Branş Denemesi çözülür + günlük kotalı İki Desteli Anki döngüsü zaten arka planda devam eder.
- **Orta Volatiliteli Mekanizmik Dersler (Fizyoloji, Patoloji, Biyomateryal):** Ders bittikten sonra **her 10 ila 14 günde bir** 1 adet Branş Denemesi çözülür.

7.2. Biten Bir Dersin Spesifik Ünitesine Ne Zaman Dönülür? ("Takvimle Dönme Yasağı")

Bir ders tamamen bittikten sonra "Her hafta sırayla bir ünitesini okuyayım" kuralı kesinlikle yasaktır. Spesifik bir üniteye (örneğin Solunum Sistemi Anatomisi, Adeziv Jenerasyonları veya Odontojenik Tümörler) dönmenin tek bir şartı vardır: **Branş denemesi veya genel denemeden gelen "Performans Sinyali"!** Yani siz o üniteye takvim günü geldiği için değil, çözdüğünüz karma denemede o üniteden hata çıktığı için nokta atışı dönersiniz.

7.3. Denemede Yanlış Çıktığında 3 Adımlı Cerrahi Müdahale Protokolü (DUSBANKASI + Anki Entegrasyonu)

Pashler ve ark. (2005) ile Butler, Karpicke ve Roediger (2008) tarafından yapılan deneyler, testlerde yapılan hataların onarımında **Düzeltici Geri Bildirim (T+0)** ile **Doğrulama Testinin (T+3)** birbirinden ayrılması gerektiğini kanıtlamıştır:

1. **ADIM 1 - Deneme Günü (Aynı Gün, T+0 - Sadece 5 Dakikalık "Mikro-Cerrahi Okuma" + Anında Anki Kaydı):** Denemeyi kontrol ederken yanlış yaptığınız veya iki şık arasında kaldığınız sorunun ilgili alt başlığını hemen o gün ana konu kitabınızdan açıp **5 dakika** okuyorsunuz. Hemen ardından 30 saniyede 1 cümlelik ayırt edici kuralı Anki'deki `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesine Cloze kartı olarak giriyorsunuz. Tüm üniteyi okumuyorsunuz ve o gün o üniteden ekstra soru testi çözmüyorsunuz! (Çünkü aynı gün soru çözerseniz kısa süreli bellekle %100 doğru yapıp kendinizi kandırırsınız).

2. **ADIM 2 - Denemeden 3 Gün Sonra (T+3 Günü - DUSBANKASI'ndan 15 Dakikalık "Gecikmeli Doğrulama Testi"):** Denemeyi çözdüğünüz gün, 3 gün sonrasının Blok 3 saatinde **DUSBANKASI** üzerinden doğrudan o dersin o alt başlığını seçerek **15 Soruluk Mini Doğrulama Testi** oluşturup çözüyorsunuz. DUSBANKASI sayesinde fiziksel kitaplarda sayfa arama zahmetiniz sıfırdır; konu kitabını hiç açmadan doğrudan o 15 soruya giriyorsunuz.
3. **ADIM 3 - Sonuç Kararı:** 15 soruda ≥13 doğru yaparsanız dosya kapanır (kalıcı belleğe mühürlendi). Eğer 15 soruda 3 veya daha fazla yanlış çıkarsa, sadece o soruyu değil tüm üniteyi unutmuşsunuz demektir; üniteyi Cumartesi günkü Kırmızı Kova Onarım Bloğuna yazarsınız.

7.4. Deneme Yanlışlarının 5 Tipolojisi ve Müdahale Reçetesi

Hata Tipi	Nasıl Teşhis Edilir?	Aynı Gün (T+0) Müdahalesi	3 Gün Sonra (T+3) & Anki Müdahalesi
Tip 1: Dikkat / Soru Kökü Okuma Hatası	Cevaba baktığınızda "Ben bunu çok iyi biliyordum, 'değildir / en az' ifadesini görmemişim" dersiniz.	Ana kitabı açma (Zaman kaybı). Sadece dikkatsizlik nedenini (negatif kök atlama, hızlı okuma) fark et.	T+3 testi veya Anki kartı eklenmez. Bilginiz tamdır, bilişsel konu tekrarı gerekmez.
Tip 2: İki Şık Arasında Kalma (Bulanık Ayrım)	5 şıkkı 2'ye indirdiniz ama (örn. DI Tip II vs. DD Tip II veya Sferik vs. Karışık amalgam) hangisi olduğundan emin olamadınız.	Ana kitaptan (veya Tek Sayfa PDF kıyas tablosundan) sadece o iki kavramı aç. İkisini ayıran tek kritik farkı (Ayırt Edici Kontrast) oku (5 dk).	Akşam Blok 4'te `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` Anki destesine "X vs. Y Tek Fark" Cloze kartı olarak anında ekle; Sabah Blok 1'de FSRS ile tekrar et.
Tip 3: İzole Ezber Unutması	Mekanizmayı biliyorsunuz ama spesifik bir sayıyı, enzimi, açıyı veya reseptörü hatırlayamadınız.	O tabloyu aç, 60 saniyelik fonolojik/görsel kanca (Mnemonic) kur ve Image Occlusion ile Anki Öncelikli Desteye ekle.	Ünite testi çözme; tabloyu Sabah Blok 1'deki `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` Anki döngüsünde çevir.
Tip 4: Mekanizma / Alt Başlık Çöküşü	Soruda anlatılan alt başlığı veya mekanizmayı tamamen unutmuşsunuz veya yanlış biliyorsunuz.	Ana kitaptan sadece o alt başlığı açıp 5-10 dakika "Kitabı Kapat Anlat" ile oku + kilit cümleyi Anki Öncelikli Desteye ekle.	T+3 Gününde **DUSBANKASI** (veya 2. Soru Bankası) üzerinden o üniteden 15 Soruluk Doğrulama Testi çöz. Yine çökerse Cumartesi Kırmızı Kovaya al.
Tip 5: Kurgusal / Klinik Vaka Yorum Hatası	Teorik bilgiyi biliyorsunuz ancak vaka sorusundaki klinik ipuçlarını (örn. radyografik görüntü veya hasta anamnezi) birleştiremediniz.	Sorudaki "anahtar vaka kelimesini" (buzzword) yuvarlak içine al, DUSBANKASI Favorilere ekle ve hangi tanıya işaret ettiğini Anki Öncelikli Desteye yaz.	T+3 Gününde DUSBANKASI (veya 3./4. Banka) üzerinden o üniteden 15 soruluk vaka ağırlıklı doğrulama testi çöz.

7.5. Deneme Yanlış Havuzunu Anki İçinde Nasıl Tutmalıyım? ("Pazar'a Biriktirme Yasağı" ve Anında Enjeksiyon Protokolü)

Fiziksel bir Hata Defteri tutmak yerine tüm deneme yanlış cümlelerini ve ezber tablolarını Anki'deki **`01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO`** destesinde toplamak, sabah ilk iş olarak en kritik zayıf noktalarınıza odaklanmanızı sağlayan üstün bir stratejidir. Ancak bu sistemin "Yayınevi Sendromu"na dönüşmemesi için şu **3 Kesin Kurala** uyulmalıdır:

- **Kural 1 - Pazar Gününe Kart Biriktirme Yasağı (Blok 4'te Anında 30 Saniyelik Giriş):** Hafta içi çıkan deneme yanlışlarını ve tabloları "Pazar günü topluca Anki'ye girerim" diyerek biriktirmeyin! Pazar gününe biriken 40-50 hatayı Anki'ye dizmek Pazar gününüzü 2-3 saatlik yorucu bir "veri giriş mesaisine" çevirir ve hafta içi yaptığınız hatanın sıcak bilişsel bağlamı Pazar gününe kadar soğur. Bunun yerine, akşam **Blok 4'te (veya Pazar sabah denemesi biter bitmez)** yanlış sorunun 5 dakikalık mikro-okumasını yaparken Anki penceresini açık tutun ve 30 saniyede (renk, kalınlaştırma veya süslemeyle hiç uğraşmadan) 1 cümlelik Cloze kartınızı yazıp `Enter`'a basın!
- **Kural 2 - Soru Fotoğrafı Değil, "Tek Cümlelik Zıtlık / Kırık Halka" Kartı:** Anki'ye çoktan seçmeli sorunun ekran görüntüsünü atmayın; çünkü aynı soruyu 2. kez gördüğünüzde beyniniz sorunun görsel kalıbını tanır ve mekanizmayı düşünmeden "Cevap C şıkkıydı" der. Bunun yerine Anki'ye sadece "*Ben Neyi Karıştırdım? → Doğru Ayırt Edici Kural Nedir?*" formatında tek satırlık atomik Cloze cümleleri girin:

```
• [RESTORATİF] İyontoforezde {{c1::rubber-dam}} kullanılmaz; çünkü {{c1::elektrik akımını keserek tedaviyi başarısız kılar}}!
• [RESTORATİF] ICDAS restorasyon kodlarında "{{c1::1}}" kodu yoktur (0'dan doğrudan 2'ye geçer); ICDAS çürük kodu {{c1::4}}'te dentinden gölge yansır ama kavitasyon YOKTUR.
• [PERİO/CERRAHİ] Dentin pini {{c1::Mandibular Molar Distal ve Maksiller Molar Palatinal}} köklerde KESİNLİKLE açılmaz; oysa {{c1::Endodontik Post}} için en ideal kanallar bunlardır!
• [MİKROBİYOLOJİ] {{c1::Trichinella pseudospiralis}} diğer türlerin aksine çizgili kas içinde KİSTLEŞMEZ; tanı dışkıda yumurta ile değil ({{c1::vivipardır!}}) {{c1::kas biyopsisi + eozinofili}} ile konur.
```

- **Kural 3 - Görsel/Radyografik Sorular İçin DUSBANKASI Favoriler + Görüntü Kartı:** Eğer yanlış yaptığınız soru doğrudan bir radyografi, lezyon fotoğrafı veya anatomik şekil sorusuysa; DUSBANKASI üzerinde soruyu **Favorilere** ekleyin ve sadece radyografi/lezyon görüntüsünü (şıklardan arındırılmış olarak) Anki'deki `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesine atıp altına "*Bu radyografideki patognomonik görüntü nedir ve hangi lezyonu işaret eder?*" sorusunu ekleyin.

BÖLÜM 8: 24 Ekim 2027'ye Giden Makro Yol Haritası, Günlük 4 Katmanlı SOP ve Haftalık 5+2 Master Plan

8.1. 24 Ekim 2027'ye Kadar 4 Fazlı Makro Periyodizasyon

Sınava kadar olan süreci rastgele turlar atarak değil, her fazda çalışma şeklinin, DUSBANKASI modlarının ve kullanılan soru bankasının evrildiği 4 Fazlı Periyodizasyon ile yöneteceksiniz:

Faz ve Dönem	Temel Hedef	Konu vs. Soru Oranı	Devredeki Materyal, Anki ve DUSBANKASI Modu
FAZ 1: Derin Kodlama ve Kova Triyajı (Başlangıç - Nisan 2027 Sonu)	15 dersin tamamında Ana Konu Kitabı + Çıkmış Sorular + 1. Soru Bankası (T+0 / T+3) döngüsünü tamamlamak ve üniteleri Yeşil/Sarı/Kırmızı kovalara ayırmak.	**%45 Konu** (Derin Kodlama + Boş Kağıt) **%55 Soru & Geri Çağırma**	• Tek Ana Konu Kitabı • Çıkmış Sorular (1. Tarama) • 1. Soru Bankası (%100) • DUSBANKASI / 2. Banka (Sarı/Kırmızı Kova ve T+3 doğrulama için) • İki Desteli Anki (Öncelikli Deste + Budanmış Ana Deste) • Biten dersler için DUSBANKASI Branş Denemeleri
FAZ 2: Cerrahi Onarım ve Harmanlama (Interleaving) (Mayıs 2027 - Temmuz 2027 Sonu)	Yeşil Kova ünitelerini sadece karma sorularla korumak; tüm enerjiyi Sarı/Kırmızı Kova ünitelerine ve Klinik Bilimlerin vaka sorularına (DUSBANKASI, 2. ve 3. Banka) yatırmak.	**%20 Nokta Atışı Konu Yaması** **%80 Karma Soru & Deneme**	• DUSBANKASI Karma Bloklar + 2. ve 3. Soru Bankaları • Klinik derslerde 4. Soru Bankası başlangıcı • Haftada 2 Genel Deneme + Her gün 2 Branş Denemesi • İki Desteli Anki (45 dk tavan) • Tek Sayfa PDF'lerin sadece Kıyas/Tuzak kutuları
FAZ 3: Yoğun Simülasyon ve Çeldirici Avı (Ağustos 2027 - Eylül 2027 Sonu)	Tam sınav kondisyonu, hızlanma, Türkiye Geneli denemelerin hata otopsisi ve Çıkmış Soruların 2. ve 3. kez (şıklardaki tüm kavramlarla) analizi.	**%15 Hata Otopsisi Okuması** **%85 Deneme & Soru Kampı**	• Klinik 4. Soru Bankası + DUSBANKASI Favoriler Tarama • Genel Denemeler (Haftada 3-4 adet) • Çıkmış DUS Soruları (Şık Analizli Tarama) • Anki `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` Destesi
FAZ 4: Son 24 Gün "Yüksek Volatilite Mühürleme Kampı" (1 Ekim - 23 Ekim 2027)	Yeni ve ağır kaynakları kapatıp, aylardır Anki Öncelikli Destede biriktirdiğiniz "Kırmızı Tablolar", "Deneme Hata Cümleleri", DUSBANKASI Favorileri ve "İstisnalar/Sayısal Eşikler" üzerinden Geri Çağırma Gücünü %100'e çıkarmak.	**%30 Saf Ezber & Hata Destesi** **%70 Günlük Deneme & Çıkmışlar**	• Anki `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` Destesi (Tam Tarama) • DUSBANKASI Favori Sorular Havuzu • Tek Sayfa PDF'lerin En'ler/Tuzaklar kutuları • Her sabah 10:15'te 1 Genel Deneme

8.2. Günlük 4 Katmanlı Bilişsel Çalışma Akışı (Saat Saat SOP Şablonu)

Gününüzü tek bir işe (sadece konu çalışmaya veya sadece Anki bakmaya) ayırmak bilişsel tükenmişlik yaratır. Bunun yerine gününüzü her gün sabit sırayla işleyen **4 Bilişsel Bloğa** bölüyoruz. Hem tam zamanlı (8,5-9 saat) hem de klinik/nöbet/fakülte devam ederken (5-5,5 saat) uygulanabilecek standart operasyon prosedürü aşağıdadır:

Bilişsel Blok	Tam Zamanlı	Klinik / Okul Dönemi	Blok İçinde Yapılacak Standart Operasyon (SOP)
BLOK 1: İki Desteli Anki & Mikro-Bellek Bakımı (Sabah İlk İş)	**45-60 Dakika** (08:30 - 09:30)	**45 Dakika** (Sabah İlk Blok)	• **İlk 15-20 Dk (1. Öncelik: `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` Destesi):** Kendi deneme yanlış cümlelerinizi ve Image Occlusion ezber tablolarınızı içeren öncelikli desteyi %100 sıfırlayın (Olgun tablolarda 1-2 firede Good basın, üst üste kaçan tekil maddeye Cerrahi Ayırma ile Cloze açın). • **Son 25 Dk (2. Öncelik: `02-ANA-TEMEL-BILIM` Destesi):** Budanmış temel bilim destesinden günü gelen kartları çözün. Bildiğiniz kartları @ ile Suspend edin. Toplam 45. dakika dolduğunda kart bitmese bile Anki'yi kesin olarak kapatın!
BLOK 2: Yeni Konu Edinimi ve T+0 Kalibrasyonu (Zirve Odak Saati)	**4 Saat** (09:45 - 13:45) (3 veya 4 Ünite)	**2,5 Saat** (Akşam İlk Blok) (2 Ünite)	• Ana konu kitabından günün yeni ünitelerini çalış (Her 3-4 sayfada bir 90 sn başını kaldırıp özetle). • **Ünite Biter Bitmez (T+0):** Kitabı kapat, 10 dakika boş müsvedde kağıda ünitenin iskeletini anlatarak dök, kitabı açıp eksikleri kırmızıyla işaretle. • Hemen ardından 1. Soru Bankasındaki 50 soruluk ünite testinin sadece **5'in katları olan 10 sorusunu** (veya DUSBANKASI'ndan 10 soruyu) çöz. Kalan 40 soruyu 3 gün sonraya (T+3) bırak.
BLOK 3: T+3 Gecikmeli Geri Çağırma ve Kova Triyajı (Öğleden Sonra)	**2,5 Saat** (14:45 - 17:15)	**1,5 Saat** (Akşam İkinci Blok)	• **Tam 3 Gün Önce (T-3) Çalıştığın Ünitelerin Kalan 40'ar Sorusunu Çöz:** Ana konuyu baştan okumadan doğrudan 1. Soru Bankasındaki kalan sorulara gir. • Test biter bitmez yanlış çıkan soruların paragraflarını ana kitaptan 10-15 dk oku (ve varsa Tek Sayfa PDF'in sağ alt Tuzak/Kıyas kutusuna 3 dk göz at). • Doğru yüzdesine göre üniteyi **Yeşil** (≥%85 - Sil), **Sarı** (%70-84 - T+14'e DUSBANKASI / 2. Bankadan 1 test) veya **Kırmızı** (<%70 - Cumartesiye onarım) kovaya ata. • Varsa 3 gün önceki deneme yanlışlarının 15 soruluk T+3 doğrulama testini **DUSBANKASI** üzerinden seçip çöz.
BLOK 4: Biten Derslerin Branş Denemesi ve Anında Anki Enjeksiyonu (Akşam Kapanış)	**1,5 Saat** (17:45 - 19:15)	**45 Dakika** (Gece Kapanış)	• Daha önce tamamen bitirdiğin derslerden **DUSBANKASI** üzerinden (veya 3. Soru Bankasından) 1 veya 2 adet 30-40 soruluk **Karma Branş Denemesi** çöz. • Yanlış çıkan soruların 5 dakikalık T+0 mikro-okumasını hemen o an ana kitaptan yap ve **Pazar gününe biriktirmeden** 1 cümlelik ayırt edici kuralı 30 saniyede Anki `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesine yaz. • Tip 4/5 hatalar için 3 gün sonrasının Blok 3'üne DUSBANKASI'ndan "15 Soruluk Doğrulama Testi" ekle. • **Kapanış Penceresi (Son 10 Dk):** O gün yeni eklenen ezber tablolarını Image Occlusion ile (1 veya 2 kutu halinde) Öncelikli Desteye at ve ilk gösterimini yapıp günü kapat.

8.3. Haftalık "5 Gün İlerleme + 2 Gün Konsolidasyon" Döngüsü (Yığılma Önleyici Mimari)

Haftanın 7 günü boyunca aralıksız yeni konu çalışırsanız, Sarı ve Kırmızı kovaya düşen üniteleri onaracak hiçbir zamanınız kalmaz ve sistem 3. haftada tıkanır. Bu nedenle haftayı **"5 Gün İlerleme (Pazartesi-Cuma) + 1 Gün Kova Onarımı ve Branş Taraması (Cumartesi) + 1 Gün Genel Simülasyon (Pazar)"** olarak kurguluyoruz (1 Temel + 1 Klinik ders paralel götürülür):

Gün	Blok 2: Yeni Konu + Boş Kağıt + T+0 (10 Soru)	Blok 3: T+3 Gecikmeli Esas Soru Çözümü (Kalan 40 Soru)	Blok 4: DUSBANKASI Branş Denemesi & Anında Anki Hata Kaydı
Pazartesi	• Klinik Ders Ünite 1 & 2 • Temel Ders Ünite 1 (10 dk Boş Kağıt + 1. Bankadan 5'in katları 10'ar soru)	• Geçen Cuma çalışılan ünitelerin 1. Bankadaki kalan 40'ar sorusu çözülür → Kova Triyajı!	• Biten Ders #1 Karma Branş Denemesi (DUSBANKASI 30 soru) + Yanlışların 5 dk mikro okuması ve anında Anki Öncelikli Deste kaydı.
Salı	• Klinik Ders Ünite 3 & 4 • Temel Ders Ünite 2 (10 dk Boş Kağıt + 10'ar soru)	• Geçen haftadan günü gelen **Sarı Kova (T+14)** ünitelerinin DUSBANKASI / 2. Soru Bankasından 20 soruluk doğrulama testleri.	• Biten Ders #2 Karma Branş Denemesi (DUSBANKASI 30 soru) + Yanlışların 5 dk mikro okuması ve anında Anki Öncelikli Deste kaydı.
Çarşamba	• Klinik Ders Ünite 5 & 6 • Temel Ders Ünite 3 (10 dk Boş Kağıt + 10'ar soru)	• Cumartesi onarılan Kırmızı Kova ünitelerinin kontrol testleri + Çıkmış Soru taramaları.	• Biten Ders #3 Karma Branş Denemesi (DUSBANKASI / 3. Bankadan 35 soru) + Anında Anki Öncelikli Deste kaydı.
Perşembe	• Klinik Ders Ünite 7 & 8 • Temel Ders Ünite 4 (10 dk Boş Kağıt + 10'ar soru)	• **PAZARTESİ (T-3)** çalışılan Klinik Ünite 1-2 ve Temel Ünite 1'in kalan 40'ar sorusu çözülür → Kova Triyajı!	• Pazartesi günkü Branş Denemesinde yanlış çıkan ünitenin DUSBANKASI'ndan 15 soruluk T+3 doğrulama testi!
Cuma	• Klinik Ders Ünite 9 & 10 • Temel Ders Ünite 5 (10 dk Boş Kağıt + 10'ar soru)	• **SALI (T-3)** çalışılan Klinik Ünite 3-4 ve Temel Ünite 2'nin kalan 40'ar sorusu çözülür → Kova Triyajı!	• Salı günkü Branş Denemesinde yanlış çıkan ünitenin DUSBANKASI'ndan 15 soruluk T+3 doğrulama testi!
Cumartesi (Tampon ve Kova Günü)	**YENİ KONU ÇALIŞILMAZ!** Hafta içi **KIRMIZI KOVAYA** düşen ünitelerin 45'er dakikalık yeniden inşa ve DUSBANKASI / 2. Soru Bankası (30 soru) çözümleri yapılır.	• **ÇARŞAMBA (T-3)** çalışılan Klinik Ünite 5-6 ve Temel Ünite 3'ün kalan 40'ar sorusu çözülür → Kova Triyajı!	• DUSBANKASI Favoriler havuzunun taraması + Biten derslerden 2 adet Karma Branş Denemesi ve anında Anki kaydı.

Gün	Blok 2: Yeni Konu + Boş Kağıt + T+0 (10 Soru)	Blok 3: T+3 Gecikmeli Esas Soru Çözümü (Kalan 40 Soru)	Blok 4: DUSBANKASI Branş Denemesi & Anında Anki Hata Kaydı
Pazar (Simülasyon Günü)	**SABAH 10:15:** DUS Genel Deneme Sınavı (120 Soru) ve tüm yanlışların T+0 derinlemesine Hata Otopsisi + 1 cümlelik kuralların anında Anki `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesine girişi.	• **PERŞEMBE (T-3)** çalışılan Klinik Ünite 7-8 ve Temel Ünite 4'ün kalan 40'ar sorusu çözülür → Kova Triyajı!	• Zihinsel dinlenme ve yeni haftanın T+3/T+14 görev listesinin kontrolü. (Cuma ünitelerinin T+3 testi Pazartesi çözülür).

8.4. Sistem Tıkanıklığına Karşı 5 "Acil Durum Sigortası" (24 Ekim 2027'ye Aksamadan Ulaşma Kuralları)

24 Ekim 2027'ye kadar olan süreçte hastalık, klinik yorgunluk veya özel durumlar nedeniyle çalışamadığınız günler mutlaka olacaktır. Sistemin asla çökmemesi ve vicdan azabıyla dağılmamanız için şu 5 sigorta kuralını uygulayacaksınız:

1. **Yeni Konuyu Durdur, Önce T+3 Kuyruğunu Erit:** Herhangi bir gün geriye düştüğünüzde ilk feda edilecek şey Blok 2 (Yeni Konu)'dur. Yeni konuya başlamamak sadece takvimi 1 gün kaydırır; ama 3 gün önce çalıştığınız konunun T+3 sorularını çözmemek, 3 gün önce harcadığınız 4 saatlik emeğin çöpe gitmesine neden olur! Önce eldeki T+3 sorularını eritin, sonra yeni konuya geçin.
2. **Anki "Öncelikli Deste Koruma ve İflas" Butonu:** Eğer hastalık veya sınav haftası nedeniyle Anki kartlarınız 3 gün birikirse; önce sadece `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesindeki kartları eritin. `02-ANA-TEMEL-BILIM` destesinde biriken yüzlerce kart için FSRS Helper Postpone eklentisini kullanın ve 45 dakika toplam kotasını asla aşmayın.
3. **Kırmızı Kovada "Maksimum 3 Ünite" Limiti:** Eğer bir hafta içinde Kırmızı Kovaya (<%70 doğru) düşen ünite sayınız 3'ü geçerse, bu durum yeni konuları çok hızlı ve yüzeysel geçtiğinizi gösterir. Kırmızı Kovadaki üniteler Cumartesi günü temizlenmeden Pazartesi yeni ünite hızı artırılmaz.
4. **Materyal Üretimi Nüksetmesine Karşı "2 Dakika Kuralı":** Çalışırken içinizden "Şu konunun da tek sayfa özetini/infografiğini yapay zekaya hazırlatayım" dürtüsü geldiği an durun ve kendinize şunu söyleyin: "*DUSBANKASI'ndan bu konudan 20 soru çözmek mi bana net kazandırır, yoksa 1 saat özet dizayn etmek mi?*" Cevap her zaman sorudur.
5. **İki Gün Üst Üste Sıfır Çekmeme Kuralı (Minimum Viable Day):** En kötü, en yorgun veya en hasta olduğunuz günde bile sistemi "bozuldu" saymamak için sadece Sabah Blok 1'deki 15-20 dakikalık `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` Anki destesini ve DUSBANKASI'ndan 1 adet 30 soruluk testi çözün. Zincir kırılmadığı sürece sistem ertesi gün kaldığı yerden devam eder.

8.5. DUS 2027 Adayı İçin Tek Bakışta "Durum - Yanılsama - Doğru Eylem" Hızlı Başvuru Matrisi

Karşılaştığınız Durum / İkilem	Yapılmaması Gereken Hata (Yanılsama)	Bilişsel Olarak Doğru Eylem (Doktrin Protokolü)
"Üniteyi yeni bitirdim, 1. Bankada 50 soruluk test var. Ne yapayım?"	50 sorunun tamamını sıcağı sıcağına çözmek (Soruları yakar) veya ilk 10 soruyu çözmek (Ünitenin %80'ini taramaz).	1) Kitabı kapat, 10 dk boş kağıda üniteyi anlat/çiz. 2) Testten sadece 5'in katları olan 10 soruyu (5, 10, 15... 50) veya DUSBANKASI'ndan 10 soruyu çöz. 3) Kalan 40 soruyu 3 gün sonraya (T+3) bırak.
"3 gün geçti (T+3), kalan 40 soruyu çözeceğim. Önce konuyu okuyayım mı?"	Soruları çözmeden önce "hatırlayayım" diye ana konuyu veya tek sayfa özeti baştan okumak (Geri çağırma zorluğunu öldürür).	Hayır, hiç okuma yapmadan doğrudan 40 soruyu çöz! Beyin zorlanarak hatırlasın. Okumayı test bittikten sonra sadece yanlış yaptığın kısımlar için (10-15 dk) yap.
"T+3 testinde 40 soruda 36 doğru yaptım (≥%85). 2. Soru Bankasını çözeyim mi?"	"Elimde 4 soru bankası var, hepsini bitirmeliyim" diyerek bildiğin üniteden 150 soru daha çözmek.	**YEŞİL KOVA (≥%85):** Yanlış çıkan 4 sorunun paragrafını o an oku ve üniteyi takvimden tamamen sil! 2. Soru Bankasına dokunma; onu Sarı/Kırmızı kovalara sakla.
"T+3 testinde 40 soruda 30 doğru, 10 yanlış çıktı (%75). Ne yapayım?"	Üniteyi baştan sona tekrar okumak veya yanlışları görmezden gelip geçmek.	**SARI KOVA (%70-84):** 10 yanlışın alt başlığını o gün 15 dk ana kitaptan oku. Ajandada 14 gün sonrasına (T+14) "İşaretli yerlere 5 dk bak + DUSBANKASI / 2. Bankadan 1 test (20 soru) çöz" görevi ekle.
"T+3 testinde 40 soruda 22 doğru, 18 yanlış çıktı (<%70). Konu çökmüş!"	O günkü programı bozup 2 saat o konuyu baştan çalışmak veya yapay zekaya özet çıkarttırmak.	**KIRMIZI KOVA (<%70):** Yanlışların yerini işaretle, üniteyi Cumartesi günkü "Kırmızı Kova Onarım Bloğu"na (25 dk aktif Boş Kağıt çalışması + DUSBANKASI / 2. Bankadan 30 yeni soru) ata.
"8 eşleşmeli bir ezber tablosunu Anki'ye nasıl ekleyeyim ve 1-2 fire verince ne basayım?"	8 satırı 8 ayrı karta bölmek (kart sayısını patlatır) veya olgun kartta 7 doğru 1 fire varken Again basıp tabloyu sonsuz döngüye sokmak.	Sağ sütunu tek kutu (1 kart) veya 4'lü iki kutu (Hide All, Guess One - 2 kart) yap. İlk öğrenirken fire varsa **Again** bas; olgun kartta 1-2 fire varsa 5 sn bakıp **Good** bas. Aynı madde yine kaçarsa sadece o maddeye ayrı **Tekil Cloze** aç (Cerrahi Ayırma).
"Deneme yanlışlarımı ve tabloları Pazar günü topluca Anki'ye girsem olur mu?"	Hafta içi çıkan hataları Pazar'a biriktirmek (Pazar gününü 3 saatlik dizgi mesaisine çevirir, hatanın bağlamı soğur).	Pazar'a biriktirme! Akşam Blok 4'te deneme analizi yaparken 1 cümlelik zıtlık kuralını 30 saniyede doğrudan `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` destesine gir. Sabah Blok 1'de ilk 15-20 dk önce bu desteyi sıfırla, sonra ana desteye geç.

Karşılaştığınız Durum / İkilem	Yapılmaması Gereken Hata (Yanılsama)	Bilişsel Olarak Doğru Eylem (Doktrin Protokolü)
"Denemede yanlışım çıktı, doğrulama testini nasıl yapayım?"	Soruları kesip yapıştırmak veya soru fotoğraflarını klasörde biriktirmek.	1) Aynı gün (T+0): Ana kitaptan o alt başlığı 5 dk oku; `01-KRITIK-OTOPSI-VE-TABLO` Anki destesine 1 cümlelik ayırt edici kuralı yaz. 2) 3 gün sonra (T+3): **DUSBANKASI** üzerinden doğrudan o alt başlıktan 15 soruluk Doğrulama Testi çekip çöz.

BÖLÜM 9: Akademik Kaynakça

1. Augustin, M. (2014). How to learn effectively in medical school: Test yourself, learn actively, and repeat in intervals. *The Yale Journal of Biology and Medicine*, 87(2), 207-212.
2. Bellezza, F. S. (1981). Mnemonic devices: Classification, characteristics, and criteria. *Review of Educational Research*, 51(2), 247-275.
3. Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (1992). A new theory of disuse and an old theory of stimulus fluctuation. In A. Healy, S. Kosslyn, & R. Shiffrin (Eds.), *From learning processes to cognitive processes: Essays in honor of William K. Estes* (Vol. 2, pp. 35-67). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
4. Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In M. A. Gernsbacher et al. (Eds.), *Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental contributions to society* (pp. 56-64). Worth Publishers.
5. Butler, A. C., Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2008). Correcting a metacognitive error: Feedback increases retention of low-confidence correct responses. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 34(4), 918-928.
6. Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354-380.
7. Deng, F., Gluckstein, J. A., & Larsen, D. P. (2015). Student-directed retrieval practice is a predictor of medical licensing examination performance. *Perspectives on Medical Education*, 4(6), 308-313.
8. Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58.
9. Ebbinghaus, H. (1885). *Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Duncker & Humblot.
10. Karpicke, J. D., Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2009). Metacognitive strategies in student learning: Do students practise retrieval when they study on their own? *Memory*, 17(4), 471-479.
11. Karpicke, J. D., & Blunt, J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. *Science*, 331(6018), 772-775.
12. Kornell, N., & Bjork, R. A. (2008). Learning concepts and categories: Is spacing the "enemy of induction"? *Psychological Science*, 19(6), 585-592.
13. Paivio, A. (1986). *Mental representations: A dual coding approach*. Oxford University Press.
14. Pashler, H., Cepeda, N. J., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2005). When does feedback facilitate learning of words? *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 31(1), 3-8.
15. Pashler, H., Rohrer, D., Cepeda, N. J., & Carpenter, S. K. (2007). Enhancing learning and retarding forgetting: Choices and consequences. *Psychonomic Bulletin & Review*, 14(2), 187-193.
16. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249-255.
17. Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer Science & Business Media.

18. Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving & W. Donaldson (Eds.), *Organization of memory* (pp. 381-403). Academic Press.
19. Wozniak, P. A. (1999). *Effective learning: Twenty rules of formulating knowledge*. SuperMemo Research.